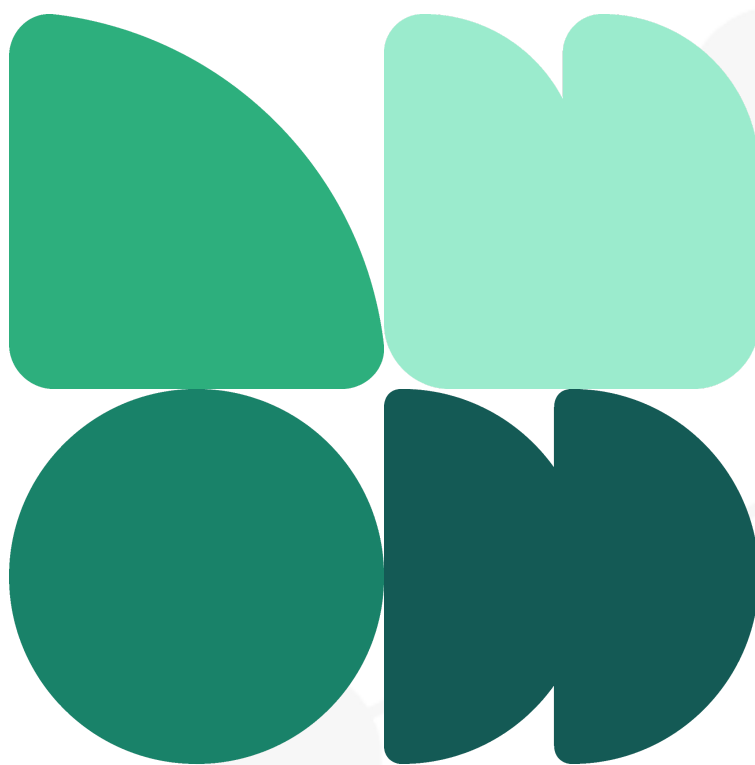


Relatório **MENSAGERIA PARA O CIDADÃO**



PARTE 1 INTRODUÇÃO	4
1.1 Evidências do uso de mensageria	5
1.2 Outras referências do uso de mensageria e seus resultados	7
1.3 Nudges: o que são as abordagens comportamentais	8
1.4 O Previne Brasil e comportamento esperado	10
1.5 Modelo de pesquisa com o usuário	11
PARTE 2 METODOLOGIA	12
2.1 Processo de Investigação Legal / LGPD	12
2.2 Desenho de Plano de Pesquisa	12
2.3 Pesquisa qualitativa com munícipes	13
2.4 Fluxo de relacionamento com as coordenadoras	13
2.5 Envio de mensagem	14
2.6 Avaliação quantitativa dos resultados	15
2.7 Avaliação qualitativa dos resultados	15
PARTE 3 RESULTADOS	15
3.1 Pesquisa qualitativa com o usuário para criação das mensagens	15
3.1.1 Mulheres com exame de citopatológicos vencidos:	17
3.1.2 Pessoas com diabetes sem hemoglobina glicada nos últimos 6 meses e Pessoas com hipertensão sem pressão aferida nos últimos 6 meses	18
3.1.3 Conclusões	19
3.2 Envio das mensagens	21
3.2.1 Efetividade em relação a realização dos exames	22
3.3 Entrevistas com coordenadores de equipe	22
3.3.1 Percepções gerais da iniciativa	23
3.3.2 Sugestões de melhorias	26
Processo de implementação da iniciativa: impressões iniciais, reunião de apresentação e comunicação com a equipe de saúde	28
3.3.3 Primeiras impressões	28

3.3.4 Reunião de apresentação e comunicação com equipe	28
3.3.5 Mensagens enviadas à população	29
3.3.6 Mensagens enviadas à população: tipo A e tipo B	30
3.3.7 Mensagens de feedback enviadas às coordenações de equipe	31
3.3.8 Impacto da iniciativa no serviço	32
3.4 Percepções da população que recebeu a mensagem enviada	34
3.5 Observações sobre o processo	36
3.5.1 Processo de Investigação Legal / LGPD	36
3.5.2 Desenho de Plano de Pesquisa	37
3.5.3 Pesquisa qualitativa com munícipes	37
3.5.4 Fluxo de relacionamento com as coordenadoras	38
3.5.5 Avaliação quantitativa dos resultados	38
3.5.6 Avaliação qualitativa dos resultados	39
PARTE 4 ANEXO	40
ANEXO A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa de conteúdo com usuários	40
ANEXO B: Entrevista COM-B de exame citopatológico	43
ANEXO C: Entrevista COM-B de pessoas com hipertensão	46
ANEXO D: Entrevista COM-B de pessoas com diabetes	49
ANEXO E: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa de mensageria	52
ANEXO F: Barreiras comportamentais	54
ANEXO G: Potenciais Técnicas de Mudança de Comportamento	57
ANEXO H: Avaliação do piloto com Coordenação de Equipe	60
ANEXO I: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Avaliação do piloto com Coordenação de Equipe	65
PARTE 5 Referências	68

PARTE I

INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde desempenha um papel fundamental no sistema de saúde de qualquer país, pois representa a porta de entrada para os serviços de saúde e é a base para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento de grande parte das condições de saúde. Ao focar na prevenção e na gestão de doenças crônicas, a atenção primária contribui para a melhoria da qualidade de vida da população, reduzindo a sobrecarga nos serviços hospitalares e diminuindo os custos globais de saúde. Entre os países da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE), aqueles com sistemas de saúde de forte orientação para APS, observa-se resultados melhores em termos de mortalidade geral, mortalidade prematura, bem como mortalidade por condições preveníveis e tratáveis (MUNDIAL, 2018).

Relatório do Banco Mundial sobre eficiência do SUS aponta uma correlação positiva entre a eficiência da APS e a da atenção de média e alta complexidade, correlação esta que é mais forte quanto mais eficiente é a APS (MUNDIAL, 2018). Atualmente, Estratégia Saúde da Família (ESF) cobre aproximadamente 65% da população brasileira; estimativas apontam que quanto maior a cobertura da ESF, mais eficiente será a APS (de 0,57 nos municípios com até 20% de cobertura a 0,65 nos municípios com mais de 80% de cobertura). A expansão da APS a 100% resultaria em ganhos de eficiência de pelo menos 0,03% do PIB (MUNDIAL, 2018).

Apesar de sua importância, os resultados dos municípios brasileiros ficam aquém das metas federais determinadas para o sistema e que funcionam como incentivo estratégico, o chamado Previne Brasil.

O uso de intervenções comportamentais, chamados nudges, pode ajudar os serviços de saúde a melhorarem seus resultados, e consequentemente, sua quantidade e qualidade de atendimentos por meio de ações de baixo custo. Decidimos por explorar o uso de mensagens via WhatsApp, que está em cerca de 99% dos smartphones no Brasil (PAIVA, 2021) para atingir os melhores resultados.

1.1 Evidências do uso de mensageria

Poucas organizações em todo o mundo utilizam eficazmente ferramentas de comunicação para fornecer soluções baseadas em evidências e com boa relação custo-eficácia para enfrentar alguns dos desafios mais significativos que as pessoas mais pobres do mundo enfrentam. A campanha de mudança social e comportamental (CMSC) entregue a grandes audiências através dos meios de comunicação social pode capacitar as pessoas a fazerem melhores escolhas sobre a sua saúde e bem-estar. Os especialistas observaram que as mensagens podem ser personalizadas. Por exemplo, podem abordar crenças erradas, reduzir medos e superar questões mais estruturais, como a fraca sensibilização para grupos oprimidos específicos.

Devido ao seu vasto alcance e aos baixos custos, as intervenções bem geridas nos meios de comunicação social podem ser extremamente rentáveis, mesmo que só consigam mudar o comportamento numa pequena proporção da população-alvo geral (BETTLE, 2022). A Founders Pledge estima que algumas intervenções nos meios de comunicação social podem ser entre quatro e 32 vezes mais rentáveis na melhoria da saúde e do bem-estar das pessoas do que as transferências monetárias incondicionais realizadas diretamente ao cidadão pela GiveDirectly (BETTLE, 2022).

Este sistema de mensagens pode preencher algumas lacunas. Por exemplo, a falta de comunicação entre cuidadores e prestadores/trabalhadores de saúde foi apontada como uma barreira à vacinação na literatura. Num estudo sobre os determinantes da vacinação, assim como o esquecimento do dia da vacinação.

No geral, existe um grande grau de heterogeneidade na literatura, com cada programa tendo um conteúdo de mensagem, modo de entrega e abordagem de inscrição diferentes. Mas sistematicamente há uma série de evidências de que as intervenções de saúde baseadas em dispositivos móveis (“mHealth”) podem aumentar a utilização de serviços de saúde:

- Uma meta-análise de 2022 de nove estudos (dos quais dois também foram incluídos na revisão de 2016) com um total de 10.348 participantes concluiu que as mulheres grávidas que recebem intervenções de saúde móvel têm maior probabilidade de ter quatro ou mais contactos de Cuidado Pré-Natal, variando com estimativas que variam entre 17% para comunicações

bidirecionais (ou seja, onde a mulher pode enviar mensagens ou ligar de volta) para 114% para comunicações unidirecionais (RAHMAN, 2022). As intervenções incluídas foram, no entanto, altamente heterogêneas, com algumas recorrendo a SMS, enquanto outras utilizam chamadas de voz, aplicações móveis, vídeos ou uma combinação destes.

- Uma meta-análise de 2019 de mensagens SMS unidirecionais em vários domínios da saúde (incluindo malária, VIH e consultas de imunização) avaliou 12 estudos com 6.448 participantes e descobriu que os lembretes por SMS aumentaram a frequência às consultas, com uma razão de probabilidade de 2,03 (LINDE, 2019).
- LUND ET. AL. (2014) avaliação do programa Wired Mothers em Zanzibar. O programa consistia em mensagens SMS unidirecionais e vouchers que permitiam a comunicação bidirecional entre as mães e seus prestadores de cuidados de saúde primários. As mulheres foram inscritas na primeira visita do cuidado pré natal. Utilizando um ECR agrupado, os autores descobriram que o programa aumenta a probabilidade de 4+ contatos de cuidado pré natal com uma razão de probabilidade de 2,39 (intervalo de confiança de 95% 1,03–5,55). O estudo incluiu 2.550 mulheres.
- Em um estudo apresentado no Terceiro Congresso Mundial de Cuidados Integrados, Cidade do México, México, de 19 a 21 de novembro de 2015, Saavedra Ramirez relatou o uso do WhatsApp como meio de comunicação dentro de um grupo de autoajuda que envolvia hipertensos. pacientes com diabetes tipo 2 e equipe médica especializada. O apoio social recebido dessa forma promoveu maior adesão dos pacientes ao tratamento e às orientações de autocuidado.

Um ponto de atenção é que as intervenções nos meios de comunicação social em particular, são muito dependentes do contexto e requerem um trabalho formativo profundo para serem bem sucedidas. As campanhas de comunicação devem ser relevantes, bem fundamentadas, entregues por mensageiros confiáveis e acionáveis. Estes factores dependem do contexto, o que significa que o que funciona num bairro pode não funcionar noutro.

1.2 Outras referências do uso de mensageria e seus resultados

Diversas outras instituições já usaram mensageria para casos de saúde pública e serviram de inspiração para este trabalho:

Instituição	Fonte	Objetivo	Resultado
Ministério da Saúde do Brasil	Fonte: Estudo publicado no Journal of Medical Internet Research em 2020	Reduzir o tempo de resposta à COVID-19	Um programa de mensagem de texto no Brasil ajudou a reduzir o tempo de resposta à COVID-19 em 24%.
Organização Mundial da Saúde (OMS)	Estudo publicado no Journal of the American Medical Association em 2017	Aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo	Um programa de mensagem de texto na Tailândia ajudou a aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo em 17%.
Governo do Reino Unido	Estudo publicado no Journal of Health Communication em 2016	Reduzir o consumo de álcool em jovens adultos	Um programa de mensagem de texto nos Estados Unidos ajudou a reduzir o consumo de álcool em jovens adultos em 11%.
Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC)	Estudo publicado no Journal of the American Medical Association em 2017	Aumentar a cobertura vacinal contra o HPV	Um programa de mensagem de texto do CDC que enviava informações sobre

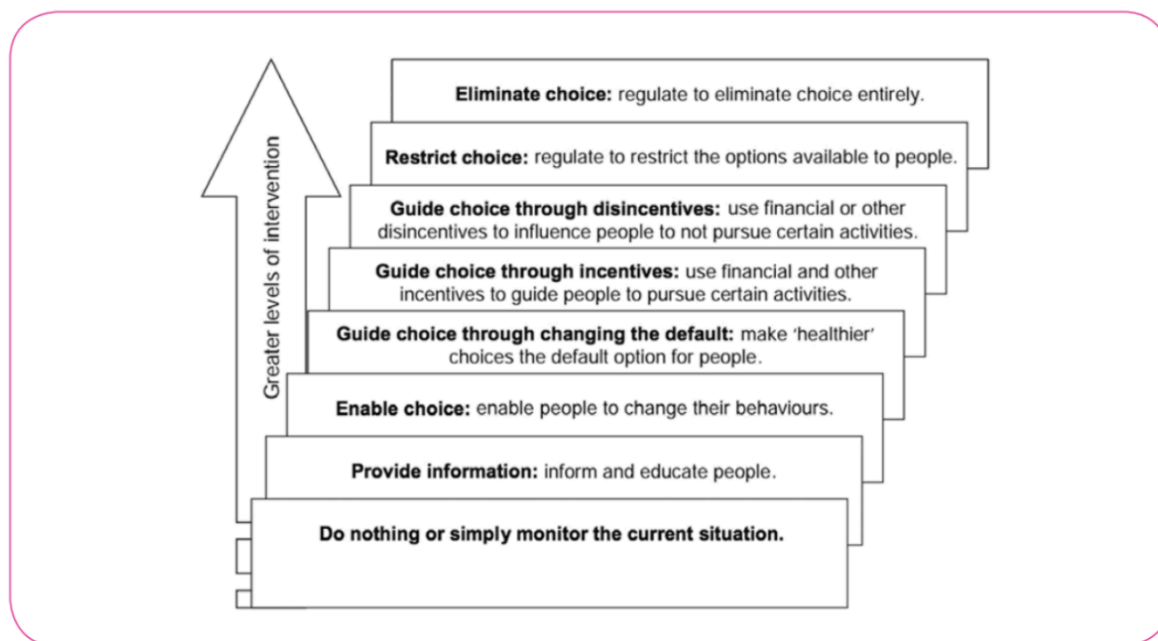
			vacinas para adolescentes aumentou a cobertura vacinal contra o HPV em 13%.

1.3 Nudges: o que são as abordagens comportamentais

Além do disparo das mensagens, o que torna claro a heterogeneidade das pesquisas, é a importância da criação da melhor estratégia para redação das mesmas.

Brosso em 2021 propõe uma estrutura conceitual baseada na neurociência da comunicação e na pesquisa em neurociência social para aumentar a eficácia das mensagens de saúde, especialmente entre comunidades de nível socioeconômico mais baixo (SES). E Caratu 2020 explora a aplicação de ferramentas de neurociência e neuromarketing em políticas públicas, especificamente na criação de campanhas de saúde pública mais eficazes. No geral, estes artigos demonstram o potencial da neuroeconomia na informação e melhoria das estratégias de mensagens de saúde pública.

O estudo da neuroeconomia tem gerado industrialmente os chamados “nudges” dentre outras abordagens comportamentais que visam explorar vieses cognitivos comuns (erros sistemáticos nos processos de pensamento) para influenciar o comportamento e a tomada de decisões. Se por um lado pesquisadores e governos têm procurado usar esses vieses para auxiliar na tomada de decisão em prol da saúde pública, com ações que visam aumentar a doação de órgãos e reduzir o consumo de açúcar, por outro, tem sido industrialmente utilizado para aumentar o consumo dos mesmos. Alguns exemplos de intervenções “nudges” em ordem de nível de interferência são:



- Obter intenções de implementação. Exemplo: “você planeja votar?”.
- Lembretes. Exemplo: e-mails ou mensagens de texto.
- Estratégias de pré-compromisso nas quais as pessoas se comprometem com um determinado curso de ação. Exemplo: parar de beber ou fumar.
- Aumentos na facilidade ou conveniência. Exemplo: colocando opções de baixo custo ou alimentos saudáveis nos locais de mais fácil acesso.
- Uso de normas sociais que enfatizam o que a maioria das pessoas faz. Exemplo: “nove entre dez hóspedes do hotel reutilizam suas toalhas”.
- Simplificação. Exemplo: remoção de complexidade para adoção de programas sociais.
- Regras padrão. Exemplo: inscrição automática em escolas.

Pretendemos combinar os resultados da pesquisa com os usuários com a teoria dos nudges para criar os textos da mensageria apropriados e efetivos para o nosso público.

1.4 O Previne Brasil e comportamento esperado

O Previne Brasil tem em seus indicadores os seguintes grupos de atendimento:

- Pessoas gestantes: com indicadores de cobertura de pré-natal, atendimento odontológico e exame de HIV/Sífilis;
- Pessoas com hipertensão: com indicador de aferição de pressão arterial;
- Pessoas com diabetes: com indicador de glicemia glicada;
- Pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos: com indicador de cobertura de exame de citopatológico;
- Crianças com menos de 1 ano: indicador de cobertura vacinal.

Considerando o indicador do Previne Brasil como já a ação de qualidade de saúde ideal para o grupo, pretendemos em municípios parceiros da ImpulsoGov de médio porte (entre 15 a 30 equipes de saúde da família) modificar o seguinte comportamento:

Grupo	Comportamento esperado
Pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos	Realização do exame citopatológico;
Pessoas com diabetes	Presença em consulta com indicador de glicemia glicada
Pessoas com hipertensão	Presença em consulta com aferição de pressão arterial

Nesse momento optamos por não trabalhar com pessoas gestantes, crianças menores de 1 ano (e suas mães), devido ao grupo ser menor e portanto exigir parceira com um maior número de municípios para que seja possível uma análise com grupo randomizado.

1.5 Modelo de pesquisa com o usuário

O modelo COM-B é um framework psicológico que se concentra na compreensão do comportamento humano e tem como objetivo explicar por que as

peessoas agem da maneira como agem. COM-B é uma sigla que se refere a três componentes-chave que influenciam o comportamento:

1. Capacidade (Capability):

- Habilidades Psicológicas: Avalia se a pessoa possui as habilidades mentais, incluindo atenção, memória, conhecimento e habilidades psicológicas, necessárias para realizar o comportamento desejado.
- Habilidades Físicas: Avalia se a pessoa possui as habilidades físicas, como capacidade de deslocamento, necessárias para realizar o comportamento.

2. Oportunidade (Opportunity):

- Ambiente Físico: Analisa as condições físicas ao redor da pessoa que podem facilitar ou dificultar a realização do comportamento.
- Ambiente Social e Normas Sociais: Avalia fatores sociais, incluindo normas sociais, influências de amigos, familiares e colegas, que podem afetar o comportamento.
- Recursos Sociais e Econômicos: Considera se a pessoa tem acesso a recursos financeiros e sociais que podem influenciar o comportamento.

3. Motivação (Motivation):

- Motivação Reflexiva (Crenças sobre Capacidade): Examina se a pessoa acredita ser capaz de realizar o comportamento e a percepção de risco e benefício.
- Motivação Automática (Emoções e Hábitos): Explora as emoções associadas ao comportamento e adiciona hábitos à motivação automática.

Uma entrevista com usuários baseada no modelo COM-B é uma abordagem que visa compreender a fundo por que as pessoas realizam ou evitam determinados comportamentos. Durante a entrevista, os pesquisadores fazem perguntas que ajudam a identificar como os três componentes do COM-B estão influenciando o comportamento dos entrevistados. Essas entrevistas fornecem informações valiosas para ajudar a desenvolver estratégias de mudança de comportamento, uma vez que identificam os principais pontos de intervenção.

PARTE 2

METODOLOGIA

2.1 Processo de Investigação Legal / LGPD

- Cotação de escritórios de advocacia;
- Recebimento do material da consultoria:
 - Relatório de Impacto à proteção de dados (RIPD);
 - Parecer jurídico;
 - Termos de uso;

2.2 Desenho de Plano de Pesquisa

- Seleção de 5 municípios a partir de ranking com os critérios de:
 - Quantidade de equipes
 - Desempenho nos indicadores
 - Tempo entre reunião de embarque e primeiro ACT assinado;

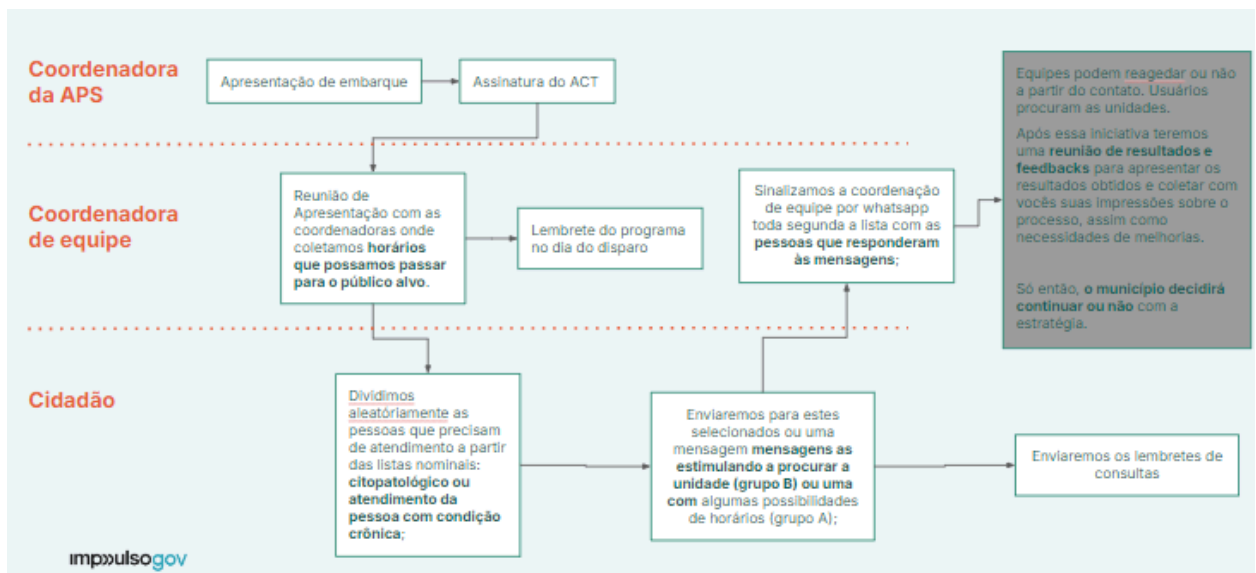
2.3 Pesquisa qualitativa com municípios

- Acompanhamento dos ACSs em visita domiciliar;
- Assinatura do termo de consentimento livre;
- Aplicação da entrevista qualitativa [Anexo B, C ou D] com municípios;

2.4 Fluxo de relacionamento com as coordenadoras

- Envio de convite para coordenações municipais de APS (COAPS) apresentando brevemente o projeto e verificando interesse em realizar projeto com a ImpulsoGov;
- Apresentação do projeto e condições de participação;
- Envio de Acordo de Cooperação Técnica (ACT);
- Reunião de Apresentação com as coordenadoras onde coletamos horários que possamos passar para o público alvo;
- Lembrete do programa no dia do disparo;

- Divisão aleatória das pessoas que precisam de atendimento a partir das listas nominais: citopatológico ou atendimento da pessoa com condição crônica;
- Envio para estes selecionados ou uma mensagem mensagens as estimulando a procurar a unidade (grupo B) ou uma com algumas possibilidades de horários (grupo A);
 - O bloqueio de agendamento é feito em 7 dias após o disparo;
 - Para grupo A é enviado um lembrete também;
- Sinalizamos a coordenação de equipe por whatsapp na segunda feira seguinte ao disparo a lista com as pessoas que responderam às mensagens;
 - Equipes podem reagendar ou não a partir do contato. Usuários procuram as unidades.
- Reunião de resultados com coordenadoras APS;
- Reunião de captação de feedbacks para coletar com impressões sobre o processo, assim como necessidades de melhorias.



2.5 Envio de mensagem

- Selecionamos pessoas de dois grupos de atendimento:

(i) Pessoas que necessitam coletar o exame citopatológico (não realizadas a pelo menos 2 anos);

(ii) Pessoas com doenças crônicas que precisam de atendimento (aferição de pressão a mais de 6 meses para hipertensos e hemoglobina glicada a mais de 6 meses para diabéticos),

- Separamos em grupos A, B e C de até 50 pessoas por grupo (i e ii) por equipe. Caso tenha menos de 150 pessoas no grupo para a equipe, é dividido igualmente por 3 pelo maior número possível. Para as pessoas do tipo A, oferecemos algumas possibilidades de horários para buscar a unidade de saúde:
 - Demos até 6 disponibilidades de dias, para as próximas semanas (entre 3 a 4 semanas) de acordo com a disponibilidade das unidades;
 - Com até 8 disponibilidades de horários;
- O agendamento é limitado para até duas pessoas por hora demonstrarem interesse;
- Enviamos as mensagens para essas 100 pessoas (A e B) de cada grupo de atendimento ao longo de 3 semanas;

2.6 Avaliação quantitativa dos resultados

- Cálculo de porcentagens de falhas do envio, cliques no “não sou eu”, por meio de contabilização de ocorrências, e fórmula no google sheets;
- Cruzamento dos dados de realização de exames no banco de dados PostgreSQL por meio de análise no Google Colab;
- Por fim, cálculo da eficiência do programa pelo método Odd-Ratio;

2.7 Avaliação qualitativa dos resultados

- Visita presencial em 3 municípios e em 1 remoto;
- Assinatura do termo de consentimento livre;
- Aplicação da entrevista qualitativa [Anexo H] com as coordenadoras de equipe;

PARTE 3

RESULTADOS

3.1 Pesquisa qualitativa com o usuário para criação das mensagens

Iniciamos a pesquisa com uma série de entrevistas com os cidadãos, visando entender barreiras físicas, psicológicas e sociais que poderiam inviabilizar o programa e dar aos pesquisadores uma intuição dos comportamentos que influenciam os mesmos a não procurarem a unidade de saúde para realizar o seu devido atendimento.

Para isso, criamos um roteiro baseado no modelo COM-B (para mais informações para ler o item 1.5 da introdução), explorando as capacidades, oportunidades e motivações do comportamento de procura por atendimento, que estão no anexo, conforme o grupo de atendimento.

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas presenciais semi estruturadas com cidadãos de municípios parceiros do Impulso Previne. Foram 19 entrevistas, divididas em 3 grupos de atendimento: pessoas com hipertensão, diabetes e mulheres para realizar citopatológico. Os entrevistados foram procurados em suas residências, por membros da ImpulsoGov acompanhados de agentes comunitários de saúde.

Foi-se apresentado os objetivos das entrevistas e os quais concordaram repassamos e pedimos a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, e após conduzimos a entrevista. A aplicação do roteiro durou entre 10 a 15 minutos. E a análise dos dados que segue abaixo foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa, usando a análise de conteúdo temática.

Grupo	Município	Quantidade de pessoas
Pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos que não realizaram exame do citopatológico nos últimos 3 anos	Amparo - SP	3
	Juquitiba - SP	4

Pessoas com hipertensão com pressão aferida a mais de 6 meses		
Pessoas com hipertensão	Amparo - SP	4
	Juquitiba - SP	2
Pessoas com diabetes com glicemia clicada a mais de 6 meses	Amparo - SP	3
	Juquitiba - SP	3

No geral, os entrevistados apresentaram algumas desconfiças e negativas em relação à abordagem da entrevista, todas acompanhadas de críticas ao sistema de saúde. Muitas vezes, os entrevistados citaram os profissionais do sistema e o tratamento recebido, como "aquela médica é péssima". Essas críticas indicam que os entrevistados têm uma visão negativa do sistema de saúde e que não confiam no atendimento que receberão.

Além disso, em muitas casas, os entrevistados não foram encontrados, o que era natural por ser um dia de semana. Os agentes comunitários de saúde citaram que uma de suas dificuldades era por conta de muitas pessoas do território trabalharem em fábricas da cidade e serem atendidas por convênios.

Em relação às capacidades psicológicas e físicas, não foi uma grande dificuldade. Apesar dos problemas físicos para se locomover até a unidade, todos possuíam meios de transporte, embora dificuldades financeiras para pagar a locomoção tenham sido citadas - um problema de oportunidade econômica. Fatores sociais e familiares não foram encontrados como limitadores para a procura de atendimento, somente os já citados relacionamento com a unidade de saúde e seus participantes.

O trabalho e as motivações, tanto reflexivas quanto automáticas, foram citadas em todos os casos como uma dificuldade. Os entrevistados relataram dificuldades em saber a rotina adequada para o cuidado com a saúde e quando procurar a unidade, não somente quando estão passando mal, mas também para prevenção. Além disso,

muitos entrevistados relataram medo de procurar o sistema de saúde e encontrar algo pior.

Algumas outras observações foram feitas especificamente aos grupos de atendimento que seguem abaixo.

3.1.1 Mulheres com exame de citopatológicos vencidos:

Em todas as entrevistas realizadas, às mulheres desconheciam o termo citopatológico, mas conheciam o “papanicolau”. Entre as palavras de sentimentos atrelados ao exame foram citados:

“Incomôdo”

“Desconfortável”

“Doloroso”

“Normal”

Apesar das palavras negativas, parte das entrevistadas realizou o exame, afirmando que os benefícios superam os sentimentos negativos em relação ao exame. Para elas, citaram que o principal motivo para a não realização do exame foi o esquecimento da sua realização. O que pode ser trabalhado em mensageria.

Em contrapartida, o outro grupo não gostaria de realizar o exame, mesmo após citar os benefícios, e mesmo afirmando acreditar na sua importância para a prevenção de câncer, que acreditam ser suscetíveis e ser uma doença importante. Afirmaram que não fariam por vergonha. Não por conta de profissionais do sexo feminino que podem ser encontradas na unidade, mas por conhecerem as pessoas que trabalham no sistema.

Em ambos os casos os sentimentos depois de se explicar os benefícios ainda foi de “medo do resultado” e “assustada”. O que são os dois motivos similares aos resultados encontrados na avaliação de barreiras para o exame de citopatológico em outras pesquisas como o [“MODELO DE CRENÇAS EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO UTERINO: COMPORTAMENTOS DE USUÁRIAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM LAGOA GRANDE-PE”](#), onde as maiores barreiras afirmadas foram, 42,6% concordar com a afirmação “Tenho medo de descobrir alguma coisa se

eu fizer o exame preventivo” e 38,4% do mesmo grupo com “Fico com vergonha de fazer o exame preventivo”.

3.1.2 Pessoas com diabetes sem hemoglobina glicada nos últimos 6 meses e Pessoas com hipertensão sem pressão aferida nos últimos 6 meses

No geral as as respostas para pessoas com diabetes e com hipertensão foram similares, tendo um bom conhecimento dos procedimentos, embora o procedimento de hemoglobina glicada seja mais conhecida como “destro” ou “teste do dedo”. Os mesmos reclamam da correria do dia para não lembrar ou conseguir marcar e do sistema de saúde ineficiente, entre frases citadas estão.

“O médico não vale nada. O retorno do exame demora de 30 a 90 dias.”

“Perdi tempo e nada foi resolvido”

“Demora muito para ter atendimento”

“Não dão atestado, nunca tem horário de manhã seria melhor.”

Por isso, as pessoas evitam ir à unidade a menos que estejam em uma situação grave, realizando os procedimentos em casa, mesmo acreditando na importância da realização com profissionais de saúde. Entre as frases estão “Minha filha faz tudo”, “Para que iria se não to passando mal”, “Eu faço tudo em casa”. Os entrevistados afirmaram encontrar dificuldades para ler e escrever, inclusive no whatsapp.

3.1.3 Conclusões

A pesquisa realizada com cidadãos de municípios parceiros do Impulso Previne identificou as seguintes barreiras para a procura por atendimento de saúde:

- Falta de confiança no sistema de saúde: Os entrevistados apresentaram uma visão negativa do sistema de saúde, citando experiências negativas com profissionais e com o atendimento recebido.
- Dificuldades de acesso: Os entrevistados relataram dificuldades de acesso à unidade de saúde, seja por conta da distância, da falta de transporte ou de horários de atendimento inadequados.
- Motivações negativas: Os entrevistados relataram medo de encontrar algo pior, vergonha de realizar o exame ou falta de conhecimento sobre a importância da prevenção.

Observações específicas para cada grupo de atendimento:

- Mulheres com exame de citopatológico vencido:
 - Apesar de conhecerem a importância do exame, muitas mulheres não o realizam por medo do resultado ou por vergonha.
 - O esquecimento também é um fator importante para a não realização do exame.
- Pessoas com diabetes sem hemoglobina glicada nos últimos 6 meses e Pessoas com hipertensão sem pressão aferida nos últimos 6 meses:
 - Os entrevistados relataram dificuldades de acesso à unidade de saúde, devido à correria do dia a dia e à ineficiência do sistema.
 - Muitos entrevistados também relataram medo de encontrar algo pior e falta de conhecimento sobre a importância da prevenção.

Ressalta-se, porém, que esta avaliação tem um escopo limitado de entrevistados que não permite uma análise com significância dos resultados. Além disso, a pesquisa poderia ser estendida não somente para analisar os comportamentos em relação a busca para a saúde, mas também para como é feita o uso da ferramenta de whatsapp.

Além de serem apenas dois municípios de um mesmo estado, sendo difícil representar as condições dos diferentes municípios em diferentes estados que serão trabalhados o programa abaixo. No entanto, por essa ser apenas uma pesquisa complementar a pesquisa bibliográfica, e uma posterior série de melhorias baseado no desempenho das mensagens, consideramos os resultados um bom ponto de partida para a escrita das mensagens.

Utilizando as barreiras de comportamento listadas no ANEXO G, junto com os resultados observados na pesquisa bibliográfica e as entrevistas, identifica-se como principal barreira para os comportamentos abaixo:

- Mulheres com exame de citopatológico vencido:
 - **Memória.** Lembrar da consulta é um comportamento que pode ser fácil de esquecer e não tem lembretes naturais.
 - **Planejamento.** O comportamento exige planejamento e preparação para ocorrer.

- **Emoções.** O comportamento pode provocar fortes emoções negativas (ansiedade e medo) em um indivíduo, dificultando praticar o comportamento.
- **Ambiente físico seguro.** O comportamento exige um ambiente físico seguro para que um indivíduo possa executá-lo.
- **Influências sociais.** O comportamento é influenciado por processos interpessoais em relação ao sistema de saúde e seus membros que podem fazer com que os indivíduos mudem seus sentimentos ou comportamentos em relação a procurar a unidade para cuidar de sua saúde.
- **Tempo.** O comportamento exige um investimento de ser executado em um determinado horário do dia.
- Pessoas com diabetes sem hemoglobina glicada nos últimos 6 meses e Pessoas com hipertensão sem pressão aferida nos últimos 6 meses:
 - **Memória.** Lembrar da consulta é um comportamento que pode ser fácil de esquecer e não tem lembretes naturais.
 - **Planejamento.** O comportamento exige planejamento e preparação para ocorrer.
 - **Hábito.** Ir a consulta pode não acontecer naturalmente no dia a dia do indivíduo e exigir uma mudança de hábito.
 - **Riscos percebidos.** Os riscos de não executar o comportamento não são memoráveis para o indivíduo.
 - **Influências sociais.** O comportamento é influenciado por processos interpessoais em relação ao sistema de saúde e seus membros que podem fazer com que os indivíduos mudem seus sentimentos ou comportamentos em relação a procurar a unidade para cuidar de sua saúde.
 - **Tempo.** O comportamento exige um investimento de ser executado em um determinado horário do dia.

3.2 Envio das mensagens

Na avaliação randomizada da iniciativa de envio de mensagens ao cidadão, observou-se um número significativo de telefones viáveis entre as fichas de cadastro. Aproximadamente 24% dos cadastros continham números de telefone. Entre esse total:

- A taxa de erro no envio (números inválidos ou não cadastrados no WhatsApp) foi de 2,6% (145 em 5.574 números) para todos os grupos com envios de mensagem (braços “A” e “B”, para as condições de crônicos e citopatológico).
- Outros 3,6% (198 em 5.574) dos integrantes deste grupo responderam as mensagens enviadas com a opção “Não sou eu”.

Para a condição do citopatológico, a taxa de agendamento de exames no braço da intervenção em que essa funcionalidade era oferecida (grupo “A”) foi de 5,2% (80 de 1.514). Esse resultado foi semelhante ao observado no mesmo grupo da intervenção para doenças crônicas - 5,4% (69 de 1.273) dos números que receberam mensagens utilizaram a função de agendamento para marcar uma consulta.

3.2.1 Efetividade em relação a realização dos exames

Quanto à efetiva realização dos exames citopatológicos, a proporção verificada após 45 dias dos envios (ou o dia de referência, no caso do grupo controle) foi de 2,6% (40 de 1.514) nos braços do lembrete *com* agendamento (grupo “A”); de 3,1% (47 de 1.514) no braço do lembrete *sem* agendamento (grupo “B”); e de 1,3% no controle (grupo “C”). Para o público com doenças crônicas, as proporções de pessoas que tiveram atendimentos registrados em suas respectivas unidades de saúde em até 45 dias após a intervenção foram de 20,7% (263 de 1.273) para os braços dos lembretes com agendamento (grupos “A”); 21% (267 de 1.273) no braço do lembrete *sem* agendamento e de 20,7% (264 de 1274) no controle (grupo “C”).

Em termos de tamanho do efeito da intervenção, esses resultados sugerem um efeito estatisticamente significativo para a intervenção com foco no exame citopatológico. A comparação com o grupo controle sugere um aumento ao redor de +110% na probabilidade de um indivíduo realizar o exame citopatológico ao receber um lembrete com opção de agendamento do que sem nenhum lembrete, sendo estatisticamente possível afirmar que, com 95% de certeza, o efeito real sobre o

aumento da probabilidade está entre +22% e +261%. Para o lembrete *sem* agendamento, o efeito adicional sobre a probabilidade de realizar o exame está ao redor de +147%, com 95% de confiança de que o valor real está entre +46% e +319%.

Já para a intervenção com foco em doenças crônicas, os resultados não sugerem uma diferença estatisticamente significativa. Para o grupo dos lembretes *com* agendamento, o efeito sobre a probabilidade de realizar uma consulta no período considerado foi de -0,3% em relação ao controle, sendo possível afirmar com 95% de confiança de que a diferença real sobre a probabilidade de realizar uma consulta está entre -14% e +16%. Para o grupo dos lembretes *sem* agendamento, o efeito foi de +1%, com 95% de confiança de que o valor real se encontra entre -13% e +18%.

3.3 Entrevistas com coordenadores de equipe

A etapa de entrevistas de avaliação do projeto piloto foi realizada com o objetivo de coletar dados detalhados sobre a percepção das coordenações de equipe da iniciativa de envio de mensagens para a população. As entrevistas foram realizadas presencialmente em três municípios, Juquitiba (SP), Inhambupe (BA) e Palmeira das Missões (RS), e de forma online em Viana (MA).

Ao todo, foram realizadas 18 entrevistas com coordenadoras de equipe, superando nossa expectativa de entrevistar 15 coordenadores, distribuídas conforme o quadro abaixo:

Município parceiro	Tipo de entrevista	Nº de entrevistas realizadas
Juquitiba	Presencial	5
Inhambupe	Presencial	5
Palmeira das Missões	Presencial	6
Viana	Online	2

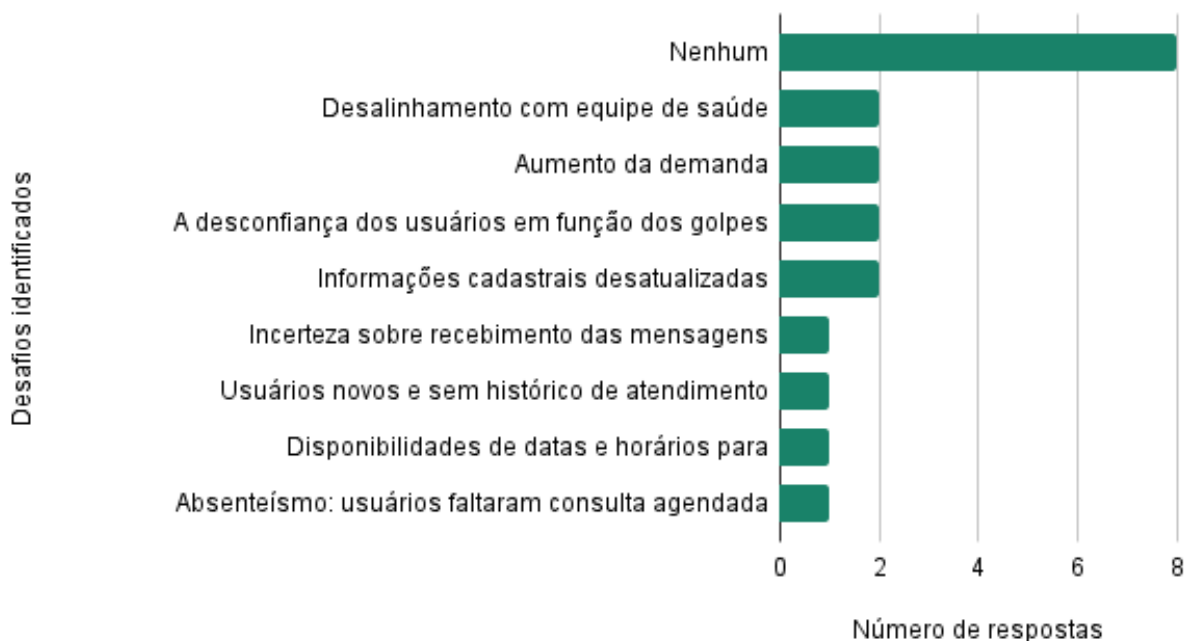
Total		18
--------------	--	-----------

3.3.1 Percepções gerais da iniciativa

O grau de satisfação com a iniciativa de Mensageria foi em média 4,6, considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “muito insatisfeito” e 5 “muito satisfeito”. Além disso, 100% das coordenadoras entrevistadas responderam que participariam novamente da iniciativa.

De todas as entrevistadas, 94% relatou que a iniciativa de mensageria trouxe benefícios ao seu trabalho, sendo os benefícios mais citados o aumento na procura por atendimento, o aumento da conscientização dos usuários sobre a necessidade de cuidado e o auxílio na busca ativa e captação de usuários.

Desafios identificados com a iniciativa



Benefícios identificados com a iniciativa



Ao abordarmos os desafios enfrentados pelas coordenadoras, 44% delas relatou que não houveram desafios durante a iniciativa. Das 66% que enfrentaram desafios com a iniciativa, os seguintes foram citados:

- Desalinhamento com equipe de saúde: houve o relato de que membros da equipe não estavam completamente a par do andamento da iniciativa e isso demandou da coordenação de equipe
- Aumenta da demanda: por menor que seja o número de atendimentos a mais a serem realizados, se estes forem demandados em momentos pouco oportunos, podem gerar bastante incômodo para a equipe assistencial
- A desconfiança dos usuários: foram muitos os relatos de que esta foi a primeira impressão de muitos usuários ao receberem a mensagem
- Informações cadastrais desatualizadas: muitos usuários possuem em seus cadastros individuais números de telefone de outras pessoas/instituições registrados como o telefone de seu ACS, da unidade de saúde, da secretaria de saúde ou de um serviço hospitalar.
- Incerteza sobre o recebimento das mensagens: as coordenadoras relataram que a falta de visibilidade de quem do território recebeu uma mensagem da Impulso foi um desafio

- Usuários novos e sem histórico de atendimento: como a iniciativa conseguiu trazer à unidade usuários que nunca tinham recebido atendimento antes, usuários não possuíam informações de saúde em seus prontuários, o que se demonstrou um desafio para as coordenadores
- Disponibilidades de datas e horários: por mais que as disponibilidades ofertadas fossem informadas pelas próprias coordenadoras, percebemos que houveram desalinhamentos entre o turno sugerido e o melhor momento para atendimento conforme o fluxo da unidade
- Absenteísmo: usuários que agendaram atendimento pelo WhatsApp acabaram faltando a consulta

No município de Juitiba, a disponibilidade de horários para agendamento pareceu ser o principal desafio enfrentado, enquanto em Inhambupe, foram as informações desatualizadas nas bases cadastrais.

Ao serem questionadas quais são os receios atuais em relação a Mensageria hoje, 66,7% respondeu que não possuem receios com a continuidade da iniciativa. Os receios que foram relatados pelos outros 33,3% das coordenadoras foram os seguintes:

- Aumento excessivo de demanda por atendimento
- Necessidade de ajuste das disponibilidades oferecidas para agendamento
- Medo da população desqualificar a unidade por erros com disponibilidades de agendamentos
- Receio das mensagens não atingirem/impactarem público idoso
- Receio da falta de continuidade da iniciativa

3.3.2 Sugestões de melhorias

Abaixo estão as sugestões de melhorias citadas pelas coordenadoras de equipe, indicando quais foram citadas mais de uma vez:

- *Continuidade da iniciativa*
 - Continuidade dos disparos iniciados com público de citopatológico e condições crônicas (4 citações)

- Continuidade de trabalho em campo, para melhor compreender as dificuldades enfrentadas nos municípios
- *Público-alvo das mensagens*
 - Ampliar o número de pessoas que recebem mensagens, visto que há capacidade do serviço de saúde realizar mais atendimentos (2 citações)
 - Realizar disparo de mensagens focado na busca ativa para atualização vacinal de crianças (5 citações)
 - Sobretudo com crianças menores de um ano
 - Realizar disparo de mensagens focado na busca ativa de gestantes (5 citações)
 - Realizar disparo de mensagens focado na busca ativa de beneficiários do Bolsa Família
 - Realizar disparo de mensagens sobre dengue para conscientização da população
 - Continuar focando no público que está em atraso com algum atendimento, pois é o prioritário de busca ativa
 - Continuar disparos testando a aceitação de outros públicos
- *Conteúdo das mensagens*
 - Mensagem pode assumir tom ainda mais impactante, mais sério e alarmante, para responsabilizar e intimidar a população a buscar atendimento (2 citações)
 - Incluir nas mensagens informações sobre o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, pois para o público de condições crônicas, sem essa especificação, cria-se a expectativa de atendimento realizado por médica/o
 - Utilizar áudio e/ou mensagens SMS para público de condições crônicas, pois muitos são idosos que não possuem smartphone, logo não têm WhatsApp ou não sabem usar
- *Ajustes operacionais da iniciativa*

- Ampliar e qualificar visibilidade das equipes de quais pessoas receberam mensagens, quais mensagens, e se houve algum retorno/agendamento realizado por elas (3 citações)
- Possibilitar que a própria unidade de saúde indique quais são os usuários que irão receber mensagens
- Alinhar envio de mensagens com maior antecedência para melhor preparo da equipe em receber usuários
- Ampliar a frequência de envio de mensagens, sugestão de um envio por mês
- Ampliar comunicação no território sobre a realização da iniciativa
- Enviar lembrete do agendamento realizado (isso já ocorreu no piloto mas a equipe teve pouca visibilidade)
- Atrelar disparo de mensagem com dia de atendimento coletivo/grupo para pessoas com condições crônicas, quando há também realização de atendimento médico

Processo de implementação da iniciativa: impressões iniciais, reunião de apresentação e comunicação com a equipe de saúde

3.3.3 Primeiras impressões

Quando questionadas qual foi a primeira impressão acerca do projeto de Mensageria, 72% das coordenadores relataram percepções muito positivas. Destaca-se o caráter inovador da iniciativa e o potencial de facilitar a comunicação no território, trazendo uma outra forma de aproximar a equipe de saúde com população assistida, chamando a atenção para o autocuidado.

As demais coordenadoras de equipe, representando 28% da amostra, tiveram as primeiras impressões mistas ou negativas. As coordenações acharam que não daria certo por um possível baixo engajamento da população e pelo público ser leigo/com dificuldade de compreensão. Também houve a percepção de que a iniciativa fosse funcionar melhor para o público-alvo de citopatológico do que de condições crônicas,

por conta deste segundo grupo ser de maioria idosa, com menos acesso e aderência ao WhatsApp.

Ao serem questionadas especificamente sobre receios gerados no primeiro contato com a iniciativa, 28% das entrevistadas relataram que não tiveram receios, enquanto 72% tiveram. Dentre as 12 entrevistadas que expressaram receios, a maior parte expressou receios envolvendo os usuários, sendo 33,3% quanto à possível desconfiança dos usuários em relação às mensagens recebidas, temendo que a falta de familiaridade com a iniciativa gerasse a interpretação de ser um golpe, e outros 33,3% temendo que os usuários não engajassem nas mensagens. Além disso, também foi citado o receio de gerar uma sobrecarga de demanda para o serviço (16,7%) e de erros cadastrais inviabilizarem a iniciativa (16,7%).

3.3.4 Reunião de apresentação e comunicação com equipe

Em relação a reunião de apresentação realizada com as coordenações de equipe, é importante mencionar que os cenários destas reuniões foram muito diferentes entre municípios, alguns sendo presenciais, outros online, sendo realizada 1 ou 2 reuniões. De forma geral, não parece ter tido problemas graves de compreensão das etapas da iniciativa, sendo que 77,8% afirmaram que a reunião foi o suficiente para entenderem o projeto e 22,2% parcialmente suficiente. Ao serem questionadas o que poderia ter sido melhorado, percebemos que os motivos citados não foram relativos à reunião mas sim ao contexto municipal ou a outras etapas da iniciativa.

A grande maioria (83,3%) das coordenadoras de equipe relataram que tiveram tempo suficiente para comunicarem suas equipes sobre esta iniciativa antes do início do envio das mensagens, que ocorreu poucas semanas depois da reunião de apresentação. Os ACS foram os principais profissionais a serem avisados sobre a iniciativa e percebemos que pode ter ocorrido falha na comunicação com outros profissionais que atuam na recepção e acolhimento das unidades (como recepcionistas e técnicas de enfermagem). Notamos que muitas coordenações de equipe avisaram suas equipes sobre a iniciativa de Mensageria através de grupos de trabalho no WhatsApp.

3.3.5 Mensagens enviadas à população

Em relação ao conteúdo das mensagens enviadas, 44,4% das entrevistadas achou este adequado à população de seu território, 50% achou parcialmente adequado e apenas 5,6% achou inadequado.

As coordenadoras relataram, em diferentes municípios, que é essencial utilizar o termo "exame preventivo" ao se referir à coleta do citopatológico. Elas destacaram que as mensagens não poderiam ser mais longas do que foram, pois se fossem maiores, os usuários poderiam não lê-las. Notaram também que a mensagem parecia mais adequada para o público-alvo de citopatológico do que para aqueles com condições crônicas.

Além disso, relataram uma falta de comunicação inicial sobre o conteúdo das mensagens, o que dificultou a explicação para a população. É essencial que as equipes estejam cientes da mensagem antes do envio.

Em Juquitiba, foi observado que as sugestões de qualificação das mensagens refletiam uma preferência das coordenadoras pelas mensagens do tipo A, em vez das mensagens do tipo B.

Para que a mensagem ficasse mais qualificada, as coordenações sugeriram algumas adequações:

- Adicionar informações da unidade de saúde: adicionar o nome da unidade de referência e o telefone de contato
- Adicionar áudio em conjunto com a mensagem, sobretudo para usuários com condições crônicas, por muitos serem idosos com dificuldade de usar tecnologia ou por analfabetismo da população
- Orientar “Compareça à sua unidade de saúde caso você não tenha esta condição de saúde”, devido ao alto número de usuários com identificação errada de condição crônica em prontuário
- Orientar “Compareça à sua unidade de saúde caso você tenha realização da coleta do citopatológico em serviço/clínica privada”
- Destacar a confidencialidade do atendimento para coleta de citopatológico, devido a vergonha e/ou receio da comunidade em realizar procedimento na unidade.

- Adicionar informação sobre o rastreio do câncer de mama junto à mensagem de citopatológico
- Adicionar “opções” na mensagem, como botão para voltar e mais detalhamento sobre disponibilidades para atendimento

3.3.6 Mensagens enviadas à população: tipo A e tipo B

Aprofundando os tipos de mensagens enviadas, sendo a “tipo A” aquela COM disponibilidades de horários para agendamento e a mensagem “tipo B” aquela SEM horários disponibilizados para agendamento, apenas com incentivo à procurar a unidade de saúde.

A maior parte das coordenadoras (81,25%) acharam que as disponibilidades oferecidas na mensagem “tipo A” estavam adequadas ao fluxo de atendimento da unidade, duas coordenadoras (12,5%) acharam parcialmente adequada e uma (6,25%) achou inadequada.

No que se refere às mensagens do “tipo B”, 77,8% das entrevistadas relataram que pessoas que receberam desse tipo buscaram a unidade para atendimento, enquanto 16,6% relataram que não houve procura deste público e 5,6% não soube confirmar.

Naquelas unidades em que a mensagem “tipo B” acarretou em procura pelo serviço de saúde, 38,5% das coordenadoras relataram que realizaram agendamento de consulta para os usuários, 30,7% relatou que realizaram o atendimento por demanda espontânea no mesmo momento, 15,4% priorizou o atendimento por demanda espontânea mas precisou também agendar consulta em algumas situações e 15,4% orientaram o dia correto para buscar a unidade para atendimento.

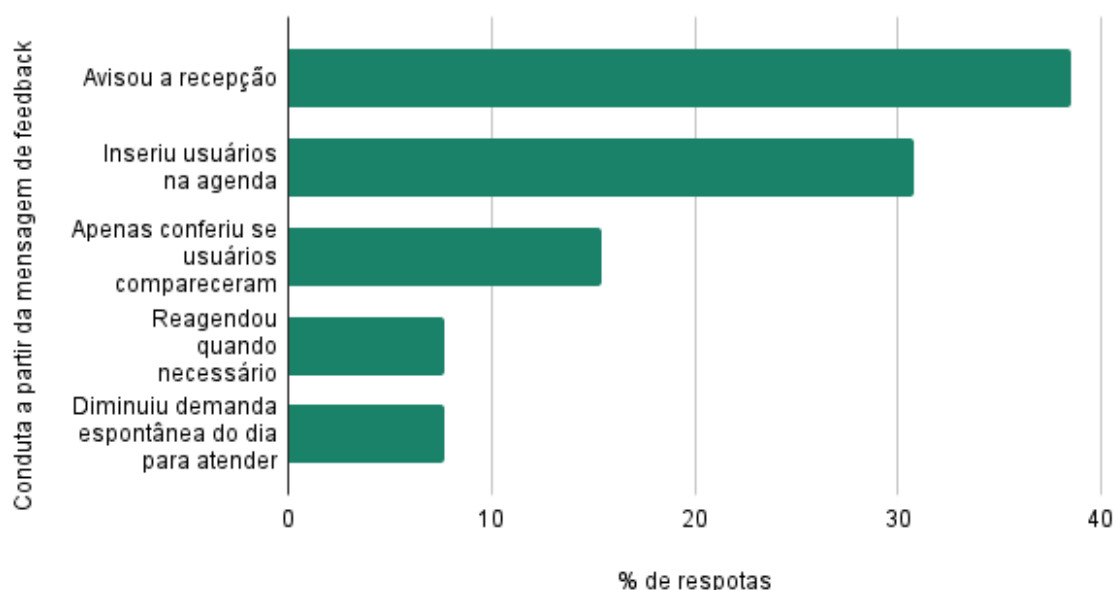
3.3.7 Mensagens de feedback enviadas às coordenações de equipe

Em relação à mensagem de feedback, indicando os usuários que agendaram atendimento pelo WhatsApp, 39% relataram não terem recebido a mensagem. Houve o relato de coordenadoras que não lembravam do recebimento da mensagem, alegando que são muitas as informações compartilhadas no WhatsApp e isso pode facilmente ter se perdido. Também houveram dificuldades com o número de telefone registrado.

Dentre as coordenações que receberam, ao serem questionadas se a mensagem de feedback foi o suficiente para que pudessem garantir atendimento dessas pessoas conforme o agendamento, 64% achou a mensagem suficiente e 36% achou parcialmente suficiente. Para que o atendimento fosse garantido, as coordenações relataram precisar do nome completo dos usuários, e não apenas o primeiro nome, como foi enviado.

A partir dessa mensagem de feedback, para garantia do atendimento das pessoas, as coordenadoras relataram que deixaram avisado na recepção os agendamentos, inseriram diretamente os usuários nas agendas do dia, conferiram se os usuários compareceram, diminuíram a disponibilidade de demandas espontâneas para aquele dia e reagendaram os usuários para outro dia, quando necessário. A frequência de respostas foi conforme este gráfico:

Conduta a partir da mensagem de feedback

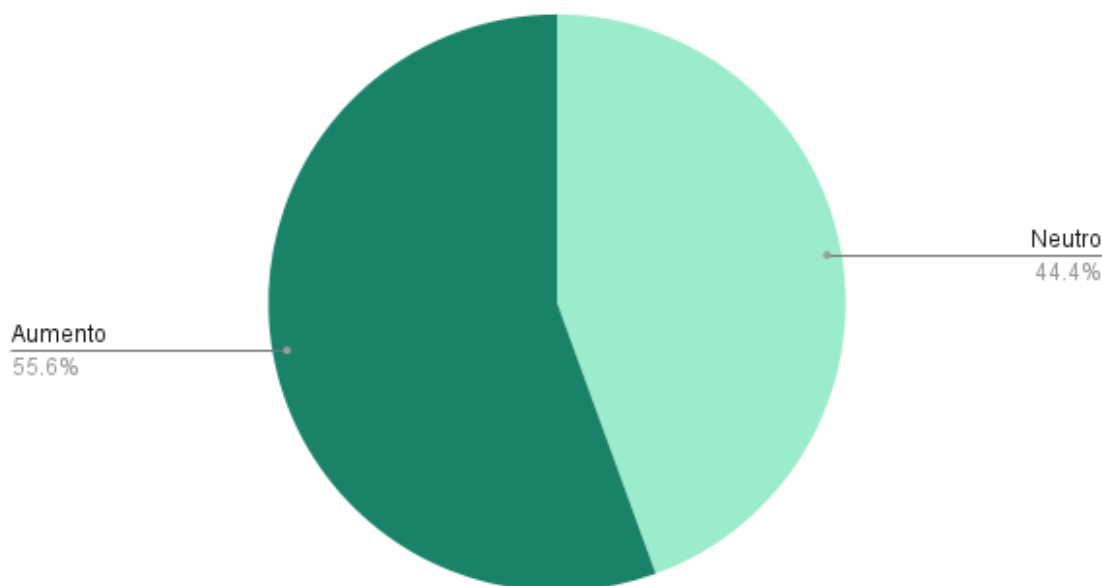


3.3.8 Impacto da iniciativa no serviço

Após o envio de mensagens, 55,6% das coordenadoras relataram que houve um aumento na procura dos serviços e 44,4% relataram que o efeito foi neutro. Não

houveram relatos de diminuição da demanda por atendimento de citopatológico ou condições crônicas.

Que efeito a iniciativa teve na procura de serviços?

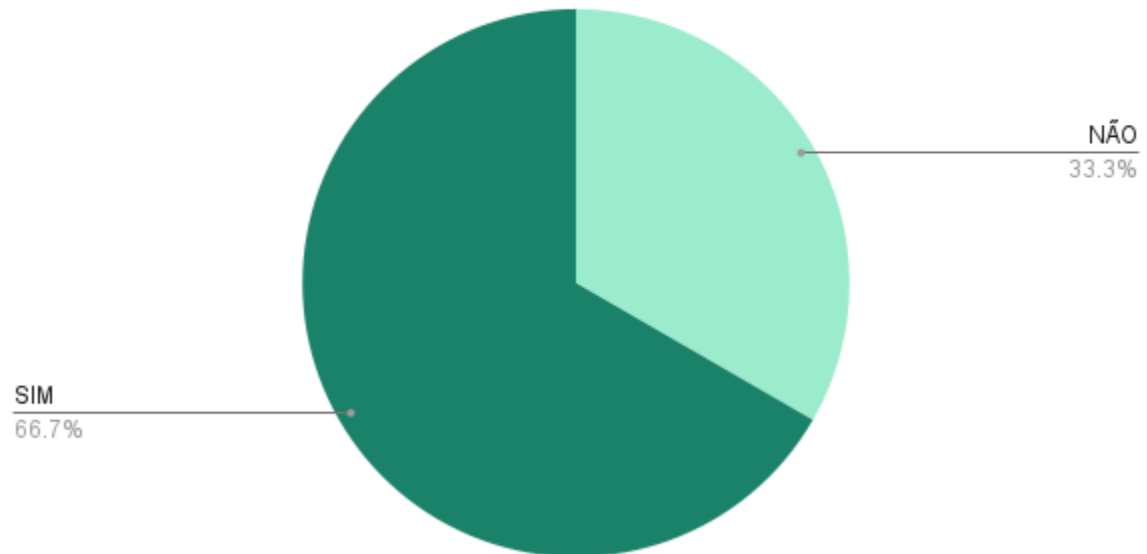


Dentre as coordenadoras que indicaram um aumento na procura do serviço de saúde, 90% relatou que foi possível atender a demanda gerada, algumas relatando que a adaptação foi tranquila e poderiam dar conta de ainda mais atendimentos decorrentes das mensagens. Apenas uma coordenadora indicou que em determinado dia não foi possível realizar todos os atendimentos, sendo necessário orientar a população a retornar em outro dia. Nota-se, também, que este aumento não foi constante entre as equipes de uma mesma unidade (como as mensagens engajarem mais no território de uma equipe do que de outra) e não foi constante entre os diferentes públicos testados (houve maior aumento de demanda para citopatológico do que para condições crônicas).

Em relação às pessoas que procuraram a unidade de saúde para atendimento após o recebimento de mensagens, 66,7% das coordenadoras notaram uma mudança no perfil do público que buscou atendimento. A iniciativa impactou pessoas que não acessavam a unidade há bastante tempo, e/ou não estavam sendo impactadas pelas buscas ativas dos Agentes Comunitários de Saúde. Embora houve relatos como esse

para os dois público-alvo que trabalhamos, recebemos mais relatos desse tipo referente à coleta de citopatológico.

A equipe percebeu diferença no público que recebeu atendimento?



3.4 Percepções da população que recebeu a mensagem enviada

Apesar de não ter ocorrido entrevistas com o cidadão pós-realização do projeto, foi possível na visita de campo, especialmente do município de Palmeira das Missões encontrar alguns usuários que foram impactados pelo programa. Houve uma diferença significativa das respostas entre o público alvo de citopatológico e de crônicos.

Em uma das primeiras visitas, se encontrou uma usuária que tinha recebido o tipo de mensagem A em que era possível agendamento em que a mesma agendou e procurou a unidade completando todo o ciclo do produto. A mesma ao ser perguntada sobre sua experiência com o produto relatou:

“Me ajudou que eu era desinteressada, aí eu percebi que precisava fazer [o exame]. Se pudesse me avisar sempre [por Whatsapp] eu gostaria.

(...) Eu achei muito prático, foi só chegar e mostrar o celular. Agora to com a saúde em dia sem precisar enfrentar fila.”.

Outras duas usuárias alegaram que não sabiam se tinham recebido a mensagem e ao pesquisar dentro do WhatsApp descobriram que sim. Uma não tinha percebido o conteúdo da mensagem pois outra pessoa tinha mexido no celular e a outra recebeu mas não deu atenção no momento. A usuária também disse que se sentiria feliz em receber as mensagens e que facilitaria a procura na unidade, mas tem medo de cair em algum golpe.

Uma usuária que inclusive era uma ACS estava com o número registrado como se tivesse clicado na opção “Não sou eu”. Ao ser questionada sobre isso verificou e descobriu que o número de sua ficha de cadastro na verdade pertencia ao seu marido e que seu marido que tinha clicado no botão de “não sou eu” e não a informado. A mesma não sabia disso, o que demonstra como os núcleos familiares não necessariamente funcionam para disseminação das informações de conscientização de saúde.

Todas as usuárias entrevistadas esse citopatológicos normalmente procuram a unidade presencialmente para poder agendar suas consultas e exames.

Outros relatos do impacto para o cidadão de citopatológico foram captados com coordenadores de equipe nos municípios de Juitituba:

“Porque o principal benefício é que impacta muito os pacientes, sabe? Eles sentem que alguém se importa em saber que não fez o exame ou que não tem procurado a unidade. Com as mensagens eu notei uma procura pelo exame. Tinha uma pessoa que fazia 13 anos que não fazia o papanicolau. Eu até printei a mensagem e mandei para quem não tinha recebido falando que elas iam receber e que tinham que fazer o exame.”

“O programa foi ótimo porque minha mãe recebeu mensagem para fazer o papanicolau, a secretária que trabalha aqui recebeu mensagem e fazia 5 anos que ela não fazia [o exame].”

Já para crônicas diferentemente, houve muitos relatos de ausência de recebimento de mensagens. A ausência de recebimento de mensagens foi decorrida de alguns fatores: algumas pessoas afirmaram que trocaram de número, o que fazem constantemente, e outras pessoas que pertenciam a familiares. Diferente do notado em citopatológico, os familiares que eram esposa e filha repassaram as mensagens aos mesmos e eles realizaram o atendimento.

Outro ponto é que todos os usuários alegam que já vão de seis meses até as unidades fazerem a renovação da receita, entretanto os mesmos não faziam a realização do exame mostrando que talvez a troca de comportamento mapeada estava errada e o problema não era a ida a unidade e sim a realização do exame. Uma das usuárias afirmou que media a pressão somente no aparelho de casa e só faz na unidade quando a pressão está extremamente alta e está passando mal. Outro usuário identificou que não usa o WhatsApp e prefere ligação.

3.5 Observações sobre o processo

O projeto demonstrou uma capacidade notável de se adaptar rapidamente aos desafios, com a ajuda de ferramentas avançadas como o ChatGPT e processos bem estruturados, o que possibilitou a realização de entregas significativas de forma eficiente. No entanto, houve falhas em termos de não dar atenção suficiente à confiabilidade das mensagens enviadas e na alocação de recursos humanos, que poderiam ter sido mais robustos. Um aprendizado importante foi que os municípios necessitam de uma abordagem de comunicação visual e de fluxos de trabalho mais detalhadamente planejados para garantir a eficácia das interações e das operações realizadas. Em detalhes a experiência aconteceu da maneira abaixo:

3.5.1 Processo de Investigação Legal / LGPD

O processo de consultoria legal para o projeto teve seus sucessos e desafios. Quatro escritórios foram consultados, permitindo uma comparação de cotações e a escolha de um que demonstrou entender bem as necessidades do projeto. Um parecer legal foi obtido a tempo para a execução do projeto, o que foi crucial. No entanto,

houve falhas: o parecer demorou um mês a mais do que o esperado e a qualidade e profundidade das recomendações ficaram aquém do necessário, faltando detalhes importantes.

Os aprendizados tirados incluíram a importância de pedir exemplos concretos de trabalhos anteriores ao escolher uma consultoria e inquirir sobre o modelo de entrega. Foi destacada também a necessidade de revisitar os critérios de proteção de dados (LGPD) em outras fases do projeto, além de finalizar os textos das mensagens antes de receber o parecer legal. Outro ponto de aprendizado foi a necessidade de melhor alinhamento com o setor financeiro (GI) quanto às datas de pagamento, para evitar tentativas de antecipação de pagamentos antes da conclusão das entregas, conforme estabelecido em contrato.

3.5.2 Desenho de Plano de Pesquisa

A seleção dos municípios tiveram resultados positivos pois os mesmos engajaram no produto.

3.5.3 Pesquisa qualitativa com munícipes

O uso do método COM-B, uma abordagem de pesquisa comportamental, foi implementado para otimizar a comunicação através do WhatsApp, visando explorar as capacidades e motivações do público alvo, que se mostrou de difícil acesso. Esse método se provou muito eficiente na criação de roteiros e na captura de conhecimentos relevantes, além de acelerar o processo de pesquisa. No entanto, houve uma falha no processo por não ter submetido o projeto a um comitê de ética antes de começar, o que poderia ter facilitado a publicação dos resultados e garantido conformidade ética. Um aprendizado crítico foi a constatação de que não é possível realizar pesquisas de forma apressada, especialmente quando se tratam de municípios próximos a grandes centros como São Paulo, exigindo um planejamento mais adequado do tempo necessário para a realização das pesquisas de maneira eficaz.

3.5.4 Fluxo de relacionamento com as coordenadoras

Essa etapa teve vários sucessos, incluindo a rápida despriorização de tarefas menos críticas, e elogios dos parceiros por adaptabilidade às mudanças, como alterações de conteúdo das mensagens pós-apresentação. Os conteúdos desenvolvidos foram bem recebidos, e o conceito de automação dos envios foi eficaz, contribuindo para reduzir a carga de trabalho das coordenadoras de equipe. A quantidade de disparos efetuados foi gerenciada com sucesso através de um sistema de escalonamento.

No entanto, essa parte enfrentou desafios significativos, o intervalo prolongado entre a reunião de ação corretiva (ACT) e o envio de mensagens também foi um problema, assim como a hesitação que causou atrasos no segundo disparo de mensagens.

Os aprendizados do projeto destacaram que captar contatos de profissionais de todas as equipes é um processo demorado e a eficácia de tal iniciativa permanece incerta, dado que despriorizados o envio de conteúdo para toda a equipe como era o conceito inicial. Também foi identificada a necessidade de uma comunicação mais detalhada com as coordenadoras de equipe sobre o envolvimento no programa, além da importância de enviar lembretes sobre os disparos antes dos mesmos e fornecer exemplos claros. Também ficou evidente que explicações sobre o processo por telefone são ineficazes sem o suporte visual adequado.

3.5.5 Avaliação quantitativa dos resultados

A avaliação quantitativa dos resultados procedeu-se conforme planejado. Uma das dificuldades foi a baixa certeza na avaliação dos resultados, era necessário uma amostra maior com fim de obter dados mais acurados da intervenção. Outro problema foi que havia pessoas que tinham realizado o exame e que receberam a mensagem diminuindo a efetividade do programa. A decisão de não enviar mensagens para todas as equipes em Viana, o que comprometeu a significância estatística dos resultados. Além disso, havia disponibilizações variadas de horários entre municípios, e a interface tinha diversos problemas, como ausência de botão de voltar.

Apesar desses problemas, os resultados foram positivos como descrito acima. O projeto conseguiu não só nos dar informações sobre efetividade mas problemas no processo. Alcançando a marca de mais de 5000 pessoas contatadas foi revelado vários problemas potenciais no processo de envio, incluindo os erros quando havia a presença de caracteres especiais nas variáveis e as variações nas respostas recebidas.

Os aprendizados extraídos incluíram a necessidade de melhorar o processo de registro e filtragem dos números de telefone, que se mostrou demorado e conflituoso, especialmente com as políticas da Meta. Além disso, foi reconhecida a importância de alocar tempo suficiente dentro do calendário de Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Impacto (PMAI) para revisões necessárias, como a da calculadora de custo-efetividade, cuja atualização foi adiada para o próximo quadrimestre.

3.5.6 Avaliação qualitativa dos resultados

A realização da avaliação quantitativa foi realizada com sucesso, mas só foi possível devido a realização presencial das mesmas. Teve-se muitas dificuldades em encontrar todas as coordenadoras que estão sempre com alguma limitação de horário.

PARTE 4

ANEXO

ANEXO A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa de conteúdo com usuários

Apresentação:

O Senhor ou a Senhora _____ (nome social), nascido/a na data de _____, no município de _____, está sendo convidado (a) a participar do estudo mensageria para atenção primária no Brasil.

Este documento é um termo de consentimento livre e esclarecido – isto significa que ele serve para documentar a sua concordância em participar da pesquisa, sem nenhum tipo de pressão e com todas as informações importantes sobre a sua participação.

a) Objetivo:

A pesquisa tem três objetivos principais:

- Em mulheres de 25 a 60 anos que não realizaram o exame citopatológico nos últimos 3 anos, a pesquisa tem como objetivo entender os fatores que influenciam a não realização do exame citopatológico.
- Pessoas com hipertensão que não aferiram a pressão arterial nos últimos 6 meses, a pesquisa tem como objetivo entender os fatores que influenciam a não aferição da pressão arterial.
- Pessoas com diabetes que não mediram a glicemia nos últimos 6 meses, a pesquisa tem como objetivo entender os fatores que influenciam a não realização da medição da glicemia.

Para isso, será realizada uma entrevista com perguntas sobre o conhecimento, as atitudes, as percepções e os comportamentos relacionados ao comportamento de saúde preventiva.

b) Descrição da pesquisa:

A pesquisa será realizada por meio de entrevistas estruturadas. As entrevistas serão realizadas por um(a) pesquisador(a) treinado(a) e durará aproximadamente 30 minutos.

c) Riscos e benefícios:

Não há riscos conhecidos associados a esta pesquisa.

d) Benefícios potenciais incluem:

- Contribuir para o conhecimento sobre os fatores que influenciam o comportamento de saúde;
- Desenvolver estratégias para melhorar o comportamento de saúde.

e) Direitos do participante:

A participação na pesquisa é voluntária. Se você concordar em participar, será solicitado a assinar este TCLE e responder a uma entrevista. Você tem o direito de:

- Recusar-se a participar da pesquisa;
- Parar de participar da pesquisa a qualquer momento;
- Solicitar uma cópia dos dados coletados sobre você.

e) Confidencialidade:

Todas as informações coletadas durante a pesquisa serão mantidas confidenciais. Seus dados não serão compartilhados com terceiros. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante.

f) Consentimento:

Ao assinar este TCLE, você concorda em participar desta pesquisa. Você pode retirar seu consentimento a qualquer momento, sem penalidade.

g) Acompanhamento:

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é Gabrielle Arruda Costa da Silva, que pode ser encontrada no telefone +5511940211447, ou contactada pelo e-mail gabrielle@impulsogov.org.

h) Do uso de ferramentas virtuais

Este estudo está sendo realizado à distância, usamos ferramentas online como whatsapp para videoconferência, google docs para registro das respostas e google forms para formulários online. Estas ferramentas têm política de dados e privacidade condizente com a legislação nacional, e não repassam, por exemplo, os dados a terceiros. Como vale em qualquer uso da internet, não podemos garantir que os

ambientes virtuais onde estão armazenados os dados não sejam alvos de invasões. No entanto, todas as medidas de segurança cabíveis foram tomadas para evitar este tipo de ocorrência, tais como uso de senhas complexas e seguras para protegê-los. Qualquer dado salvo no servidor ou nos computadores que serão usados para a análise dos dados é completamente anonimizado, de forma que não é possível relacionar os seus dados experimentais à sua identidade. Os dados originais coletados são armazenados em formato codificado, protegidos com senha forte.

Assinatura do participante:

[Nome do participante]

Data:

ANEXO B: Entrevista COM-B de exame citopatológico

Objetivo: Entender os fatores que influenciam a não realização do exame citopatológico por mulheres de 25 a 60 anos.

Público-alvo: Mulheres de 25 a 60 anos que não realizaram o exame citopatológico nos últimos 3 anos.

Material:

- Documento com as perguntas
- Software registrador de entrevistas

Procedimento:

1. Apresente-se ao participante e explique o objetivo da entrevista.
2. Solicite que o participante assine um termo de consentimento livre e esclarecido.
3. Leia as instruções do formulário de entrevista COM-B ao participante.
4. Responda a quaisquer perguntas que o participante possa ter.
5. Colete as respostas do participante no formulário de entrevista.
6. Agradeça ao participante pelo seu tempo.

Perguntas - *Capacidade*, *Motivação* e *Oportunidade*

Habilidades psicológicas e Motivação emocional

- "Você sabe o que é um exame citopatológico?" ☐ Sim ☐ Não
 - "Poderia descrever o que é por favor?"

☐ Soube descrever ☐ Não Soube

- "Você sabe o que é um exame papanicolau?" ☐ Sim ☐ Não
 - "Poderia descrever o que é por favor?"

☐ Soube descrever ☐ Não Soube

- "Você já fez um exame desses?" ☐ Sim ☐ Não
 - Se não -> "Por que?"
 - Se sim -> "Qual a última vez? Por que?"

- Descrever o que é o exame e reavaliar se a pessoa tinha feito ou não ☐ Tinha

☐ Não Tinha

- "Como você se sentiria ao fazer um exame citopatológico?"
- "Você acha que o exame citopatológico é doloroso?" ☐ Sim ☐ Não

- "Você acredita que o exame citopatológico é importante?" ☐ Sim ☐ Não
- "De quanto em quanto tempo você tem que refazer o exame?" Avaliar se soube

responder: ☐ Sim ☐ Não

- "Você sabe o que é câncer de colo de útero?" ☐ Sim ☐ Não
- "Você sabe como o exame influencia o câncer de colo de útero?" ☐ Sim ☐ Não
- "Como?"
- "Você acredita que fazer o exame preventivo pode ajudar a detectar o câncer

precocemente?" ☐ Sim ☐ Não

• "Você acredita que fazer o exame preventivo diminui a chance de morrer de câncer do Colo do Útero?" ☐ Sim ☐ Não

- Explicar como influencia.

- "Você acredita que vai ter câncer de colo de útero?" ☐ Sim ☐ Não
- "Você acredita que vai ter câncer de colo de útero nos próximos 5 anos?" ☐ Sim

☐ Não

- "A ideia de câncer do colo do útero te assusta?" ☐ Sim ☐ Não
- "Como você se sentiria ao fazer um exame citopatológico?"

Ambiente social

- "Você tem medo ou preocupação em relação ao exame?" ☐ Sim ☐ Não
- "Você tem vergonha de fazer o exame preventivo?" ☐ Sim ☐ Não
- "Você tem vergonha de fazer o exame preventivo com uma profissional mulher?"

☐ Sim ☐ Não

• "Você tem algum receio de julgamento familiar ou de amigos se você realizar o exame?" ☐ Sim ☐ Não

- "Qual?"

Motivação reflexiva

• "Se você quisesse ir fazer um exame desses, sabe o que você teria que fazer? Como?" ☐ Sabe como ir fazer ☐ Não sabe

- "Você sabe como marcar o exame preventivo?" ☐ Sim ☐ Não
- "Você tem a intenção de fazer o exame citopatológico em breve?" ☐ Sim ☐ Não

Não

- "Você acha que o exame citopatológico é longo?" ☐ Sim ☐ Não

- "Você acha que a espera pela consulta é longa?" ☐ Sim ☐ Não

Habilidades físicas, Ambiente físico e Recursos Sociais e Econômicos

● "Você tem alguma condição física que te impeça de ir até a unidade fazer o exame?" ☐ Sim ☐ Não

- "Você tem capacidade de se locomover até a UBS?" ☐ Sim ☐ Não

- "Como?"

● "Você tem alguma limitação financeira ou de tempo para ir até a unidade fazer o exame?"

- "Qual?"

- "Há algo mais que te impeça de fazer o exame citopatológico?"

- "Como condições climáticas ou dificuldade de agendamento...."

ANEXO C: Entrevista COM-B de pessoas com hipertensão

Objetivo: Entender os fatores que influenciam a não aferição da pressão arterial por pessoas com hipertensão nos últimos 6 meses.

Público-alvo: Pessoas com hipertensão que não aferiram a pressão arterial nos últimos 6 meses.

Material:

- Documento com as perguntas
- Software registrador de entrevistas

Procedimento:

1. Apresente-se ao participante e explique o objetivo da entrevista.
2. Solicite que o participante assine um termo de consentimento livre e esclarecido.
3. Leia as instruções do formulário de entrevista COM-B ao participante.
4. Responda a quaisquer perguntas que o participante possa ter.
5. Colete as respostas do participante no formulário de entrevista.
6. Agradeça ao participante pelo seu tempo.

Perguntas - *Capacidade*, *Motivação* e *Oportunidade*

Habilidades psicológicas e Motivação emocional

- "Você sabe o que é medir a pressão?" ☐ Sim ☐ Não
 - "Poderia descrever o que é por favor?"
☐ Soube descrever ☐ Não Soube
- "Você já fez um exame desses?" ☐ Sim ☐ Não
 - Se não -> "O que te impede de ir fazer?"
 - Se sim -> "Qual a última vez?" (Se a muito tempo) "O que te impede de ir fazer novamente?"
- "Você acredita que aferir a pressão é importante?" ☐ Sim ☐ Não
- "Você acredita que aferir a pressão com uma enfermeira é importante?"
☐ Sim ☐ Não
- "De quanto em quanto tempo você tem que fazer o acompanhamento da pressão com sua equipe de saúde?" Avaliar se soube responder: ☐ Sim ☐ Não
- "Você sabe o que é hipertensão?" ☐ Sim ☐ Não

- “Você sabe descrever para mim os riscos da hipertensão?” Avaliar se soube responder: ☐ Sim ☐ Não
 - “Você sabe o que é um AVC?” ☐ Sim ☐ Não
 - “Você sabe o que é um infarto?” ☐ Sim ☐ Não
 - “Voce acredita que fazer a avaliação da pressão diminui a chance de ter um AVC?” ☐ Sim ☐ Não
 - “Voce acredita que fazer a avaliação da pressão diminui a chance de ter um infarto?” ☐ Sim ☐ Não
 - Explicar como influencia.
- “Você acredita que vai ter um AVC ou infarto?” ☐ Sim ☐ Não
- “Você acredita que vai ter um AVC ou infarto nos próximos 5 anos?” ☐ Sim ☐ Não
- “A ideia de ter um AVC ou infarto te assusta?” ☐ Sim ☐ Não

Ambiente social

- “Você tem medo ou preocupação em relação ir ao posto de saúde fazer a aferição de pressão e acompanhamento?” ☐ Sim ☐ Não

Motivação reflexiva

- “Se você quisesse ir fazer um exame desses na UBS, sabe o que você teria que fazer? Como?” ☐ Sabe como ir fazer ☐ Não sabe
 - “Você sabe como marcar a avaliação?” ☐ Sim ☐ Não
- “Você tem a intenção de fazer acompanhamento da UBS em breve?” ☐ Sim ☐ Não
- “Você acha que a espera pela consulta é longa?” ☐ Sim ☐ Não

Habilidades físicas, Ambiente físico e Recursos Sociais e Econômicos

- “Você tem alguma condição física que te impeça de ir até a unidade medir a pressão arterial?” ☐ Sim ☐ Não
- “Você tem capacidade de se locomover até a UBS?” ☐ Sim ☐ Não
 - “Como?”
- “Você tem alguma limitação financeira ou de tempo para ir até a unidade fazer o exame?” “Qual?”

- "Há algo mais que te impeça de fazer a avaliação?"
 - "Como condições climáticas ou dificuldade de agendamento...."

ANEXO D: Entrevista COM-B de pessoas com diabetes

Objetivo: Entender os fatores que influenciam a não realização da medição da glicemia por pessoas com diabetes nos últimos 6 meses.

Público-alvo: Pessoas com diabetes que não mediram a glicemia nos últimos 6 meses.

Material:

- Documento com as perguntas
- Software registrador de entrevistas

Procedimento:

1. Apresente-se ao participante e explique o objetivo da entrevista.
2. Solicite que o participante assine um termo de consentimento livre e esclarecido.
3. Leia as instruções do formulário de entrevista COM-B ao participante.
4. Responda a quaisquer perguntas que o participante possa ter.
5. Colete as respostas do participante no formulário de entrevista.
6. Agradeça ao participante pelo seu tempo.:

Perguntas - *Capacidade*, *Motivação* e *Oportunidade*

Habilidades psicológicas e Motivação emocional

- "Você sabe o que é medir a glicemia no sangue?" ☐ Sim ☐ Não
 - "Poderia descrever o que é por favor?"
☐ Soube descrever ☐ Não Soube
- "Você já fez um exame desses?" ☐ Sim ☐ Não
 - Se não -> "Por que?"
 - Se sim -> "Qual a última vez? Por que?"
- "Você acredita que medir a glicemia é importante?" ☐ Sim ☐ Não
- "Você acredita que medir a glicemia com uma enfermeira é importante?"
☐ Sim ☐ Não
- "De quanto em quanto tempo você tem que fazer o acompanhamento da sua glicemia com sua equipe de saúde?" Avaliar se soube responder: ☐ Sim ☐ Não
- "Você sabe o que é diabetes?" ☐ Sim ☐ Não

- “Você sabe descrever para mim os riscos da diabetes?” Avaliar se soube responder: ☐ Sim ☐ Não

- “Você sabe o que é um AVC?” ☐ Sim ☐ Não
 - “Você sabe o que é um infarto?” ☐ Sim ☐ Não
 - “Você acredita que fazer a avaliação da glicemia diminui a chance de ter um AVC?” ☐ Sim ☐ Não
 - “Você acredita que fazer a avaliação da glicemia diminui a chance de ter uma amputação?” ☐ Sim ☐ Não
 - Explicar como influencia.
- “Você acredita que vai ter uma cegueira, amputação ou AVC?” ☐ Sim ☐ Não
- “Você acredita que vai ter uma cegueira, amputação ou AVC nos próximos 5 anos?” ☐ Sim ☐ Não
- “A ideia de ter uma cegueira, amputação ou AVC te assusta?” ☐ Sim ☐ Não

Ambiente social

- “Você tem medo ou preocupação em relação ir ao posto de saúde medir a glicemia e fazer o acompanhamento?” ☐ Sim ☐ Não

Motivação reflexiva

- “Se você quisesse ir fazer um exame desses na UBS, sabe o que você teria que fazer? Como?” ☐ Sabe como ir fazer ☐ Não sabe
 - “Você sabe como marcar a avaliação?” ☐ Sim ☐ Não
- “Você tem a intenção de fazer acompanhamento da UBS em breve?” ☐ Sim ☐ Não
- “Você acha que a espera pela consulta é longa?” ☐ Sim ☐ Não

Habilidades físicas, Ambiente físico e Recursos Sociais e Econômicos

- “Você tem alguma condição física que te impeça de ir até a unidade medir a glicemia?” ☐ Sim ☐ Não
- “Você tem capacidade de se locomover até a UBS?” ☐ Sim ☐ Não
 - “Como?”

- “Você tem alguma limitação financeira ou de tempo para ir até a unidade fazer a avaliação?” “Qual?”
- "Há algo mais que te impeça de fazer a avaliação?"
 - “Como condições climáticas ou dificuldade de agendamento....”

ANEXO E: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa de mensageria

Apresentação:

O Senhor ou a Senhora _____ (nome social), nascido/a na data de _____, no município de _____, está sendo convidado (a) a participar do estudo mensageria para atenção primária no Brasil.

Este documento é um termo de consentimento livre e esclarecido – isto significa que ele serve para documentar a sua concordância em participar da pesquisa, sem nenhum tipo de pressão e com todas as informações importantes sobre a sua participação.

a) Objetivo:

A pesquisa tem como objetivo entender a eficácia das mensagens de WhatsApp na promoção da realização de consultas médicas. Para isso, será realizado o envio de mensagens e, posteriormente, coletadas informações sobre a realização das consultas, município de residência e idade dos participantes.

b) Descrição da pesquisa:

A pesquisa envolverá o envio de mensagens de WhatsApp e a coleta de informações sobre a realização de consultas médicas após o recebimento dessas mensagens. As informações coletadas incluirão dados sobre seu município e idade.

c) Riscos e benefícios:

Não há riscos conhecidos associados a esta pesquisa.

Benefícios potenciais incluem:

- Inclui contribuir para o conhecimento sobre a eficácia das mensagens de WhatsApp na promoção de consultas médicas;
- Desenvolver estratégias para melhorar o comportamento de saúde.

d) Direitos do participante:

A participação na pesquisa é voluntária. Se você concordar em participar, será solicitado a assinar este TCLE e responder a uma entrevista. Você tem o direito de:

- Recusar-se a participar da pesquisa;
- Parar de participar da pesquisa a qualquer momento;

- Solicitar uma cópia dos dados coletados sobre você.

e) Confidencialidade:

Todas as informações coletadas durante a pesquisa serão mantidas confidenciais. Seus dados não serão compartilhados com terceiros. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante.

f) Consentimento:

Ao assinar este TCLE, você concorda em participar desta pesquisa. Você pode retirar seu consentimento a qualquer momento, sem penalidade.

g) Acompanhamento:

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é Gabrielle Arruda Costa da Silva, que pode ser encontrada no telefone +5511940211447, ou contactada pelo e-mail gabrielle@impulsogov.org.

h) Do uso de ferramentas virtuais

Este estudo está sendo realizado à distância, usamos ferramentas online como whatsapp para videoconferência, google docs para registro e google forms para formulários online. Estas ferramentas têm política de dados e privacidade condizente com a legislação nacional, e não repassam, por exemplo, os dados a terceiros. Como vale em qualquer uso da internet, não podemos garantir que os ambientes virtuais onde estão armazenados os dados não sejam alvos de invasões. No entanto, todas as medidas de segurança cabíveis foram tomadas para evitar este tipo de ocorrência, tais como uso de senhas complexas e seguras para protegê-los. Qualquer dado salvo no servidor ou nos computadores que serão usados para a análise dos dados é completamente anonimizado, de forma que não é possível relacionar os seus dados experimentais à sua identidade. Os dados originais coletados são armazenados em formato codificado, protegidos com senha forte.

Assinatura do participante:

[Nome do participante]

Data

ANEXO F: Barreiras comportamentais

Barreiras relacionadas à capacidade

1. **Memória.** Um comportamento que pode ser fácil de esquecer e não tem lembretes naturais.
2. **Atenção e sobrecarga cognitiva.** O cérebro de um indivíduo só consegue lidar com um determinado número de informações de uma só vez. Um comportamento ou a forma como é comunicado pode não chamar a atenção deles.
3. **Regulação comportamental.** Um indivíduo pode usar comportamentos prejudiciais (por exemplo, beber ou fumar) para reduzir emoções negativas. Não se envolver nesses comportamentos pode exigir a capacidade de controlar muito bem as emoções.
4. **Planejamento.** Um comportamento pode exigir muito planejamento e preparação para ocorrer.
5. **Habilidades e proficiência.** Um comportamento pode ser muito difícil e exigir um certo nível de habilidades ou conhecimentos para poder executá-lo com sucesso.
6. **Equilíbrio de decisões.** Os prós e os contras do comportamento podem ter o mesmo peso, deixando o indivíduo ambivalente quanto à mudança.
7. **Destreza.** Um comportamento pode exigir habilidades motoras ou coordenação para executá-lo adequadamente.
8. **Vigor e resistência.** Um comportamento pode exigir força física e energia.

Barreiras relacionadas à motivação

9. **Hábito.** Um comportamento pode não acontecer naturalmente no dia a dia do indivíduo e exigir uma mudança de hábito.
10. **Crenças de capacidade.** Um comportamento pode exigir confiança na capacidade de executá-lo com sucesso.
11. **Crenças de valor.** Um comportamento pode exigir a crença no seu valor ou que os seus benefícios superam o custo de praticar o comportamento.

12. **Atitudes e preconceitos implícitos.** Um comportamento pode ser influenciado pelos preconceitos implícitos que os indivíduos possuem, mesmo que não tenham consciência de que possuem tais preconceitos.
13. **Riscos percebidos.** Os riscos de executar ou não o comportamento (por exemplo, riscos para a saúde ou ambientais) podem não ser conhecidos ou memoráveis para um indivíduo.
14. **Motivação intrínseca.** Um comportamento pode ser impulsionado por recompensas internas. Em outras palavras, a motivação para se envolver nisso surge de dentro do indivíduo porque é naturalmente satisfatório para ele.
15. **Recompensa.** Um comportamento pode exigir uma recompensa externa (por exemplo, dinheiro) para começar ou continuar.
16. **Intenções.** Um comportamento pode ser determinado pela prontidão de um indivíduo para executar um determinado comportamento e pela quantidade de recursos pessoais que um indivíduo está preparado para investir na execução de um comportamento.
17. **Metas.** Um comportamento pode exigir que um indivíduo estabeleça ou concorde com uma meta definida em termos do comportamento ou do resultado a ser alcançado.
18. **Emoções.** Um comportamento pode provocar fortes emoções positivas (felicidade) ou negativas (ansiedade) em um indivíduo, dificultando iniciar ou parar de praticar o comportamento.
19. **Autoimagem ou autoidentidade.** Um comportamento pode precisar ser visto como uma norma “típica” para a percepção de um indivíduo sobre sua autoidentidade.
20. **Esperança/otimismo.** A confiança de que as coisas acontecerão da melhor maneira ou de que os objetivos desejados serão alcançados.
21. **Necessidades.** Um comportamento pode ser influenciado pelas necessidades do indivíduo ou pelo déficit de algo necessário para a sobrevivência, o bem-estar ou a realização pessoal.

Barreiras relacionadas às oportunidades

22. **Normas (sociais e culturais).** Um comportamento pode ser motivado pelas atitudes e comportamentos demonstrados por outras pessoas dentro de um grupo social.
23. **Normas subjetivas.** Um comportamento pode ser afetado pela percepção do que a maioria das outras pessoas dentro de um grupo social acredita e faz. Descrever o que a maioria das pessoas faz em uma situação específica pode encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo.
24. **Influências sociais.** Um comportamento pode ser influenciado por processos interpessoais que podem fazer com que os indivíduos mudem seus pensamentos, sentimentos ou comportamentos.
25. **Contexto ambiental.** Um comportamento pode ser afetado por quaisquer aspectos da situação ou ambiente de uma pessoa que desencoraje ou incentive o comportamento.
26. **Recursos financeiros/custo.** O custo do comportamento ou dos itens necessários para a realização do comportamento pode ser uma barreira.
27. **Tempo.** Um comportamento pode exigir um investimento significativo de tempo ou a necessidade de ser executado em um determinado horário do dia.
28. **Ambiente físico seguro.** Um comportamento pode exigir um ambiente físico seguro para que um indivíduo possa executá-lo.
29. **Disponibilidade de transporte/infraestrutura.** Um comportamento pode exigir um sistema de transporte confiável e acessível ou outra infraestrutura que o permita.
30. **Leis e regulamentos.** Um comportamento pode ser influenciado por leis e regulamentos locais ou estaduais, ou pela falta de tais leis.
31. **Feedback.** Um comportamento pode precisar de um processo que permita a um indivíduo comparar seu comportamento atual com um padrão específico.
32. **Pistas comportamentais.** Um comportamento pode precisar de lembretes ou dicas em ambiente físico ou digital para lembrar um indivíduo sobre ele. As dicas podem ser colocadas no ambiente ou vinculadas a outro comportamento existente.

ANEXO G: Potenciais Técnicas de Mudança de Comportamento

COM-B CATEGORY	DESCRIPTION OF BARRIER / EXAMPLES	POTENTIAL BCTs
Knowledge (Psychological capability)	Lack Knowledge on appropriate PA/Exercise activities and guidelines/thresholds. Lack Knowledge on how to effectively perform exercise activities (beyond walking).	- Information about Health Consequences - Instruction on How to Perform the Behaviour - Biofeedback
Cognitive Skills (Psychological capability)	Insufficient training in proper technique and form for exercise activities.	- Instruction on how to perform behaviour - Model the Behaviour - Behavioural Practice/Rehearsal - Feedback on Behaviour
Memory, Attention, Decision Processes (Psychological capability)	Easy to forget the behaviour, and no natural reminders are in place.	- Prompts/Cues - Goal-Setting (Behaviour) - Action Planning - Review of Behavioural Goals
Motor Skills / Coordination (Physical capability)	May have limited physical capability (range of motion, endurance, strength, coordination) to perform exercise activities.	- Behavioural Practice/Rehearsal - Feedback on Behaviour - Graded Tasks

Capability Beliefs	Lack confidence in ability to increase their physical activity	- Behavioural Practice/Rehearsal - Focus on Past Success - Reward (Outcome) - Graded Tasks - Verbal Persuasion About Capability - Time Management
Consequence Beliefs	Do not believe the benefits of increased PA/Exercise outweigh the costs of doing the behaviour	- Provide Information on the Consequences of Behaviour - Salience of Consequences - Behavioural Experiments (linking behaviour to outcome) - Pros & Cons
Motivation & Goals	Lack Motivation to exercise or increase physical activity or it is not a priority compared to other goals.	- Goal-Setting - Cue Signaling Reward - Reward (Effort, Progress or Outcome) - Commitment - Discrepancy between current behaviour and goal - Review of Behavioural Goals - Information of Other's approval

Emotion	May be afraid of being injured or pain associated with working out or existing injury/physical limitation.	- Social Support (Emotional) - Reduce Negative Emotions (Stress Reduction) - Graded Tasks - Information about Emotional Consequences
Social Influences	Lacks positive social influences to encourage behaviour	- Social Support (Practical/Emotional) - Model the Behaviour - Social Reward - Information Provision (Others' Behaviour)
Environmental Context & Resources	Insufficient time / resources to Exercise or consistently achieve PA guidelines May not have access to suitable place for walking, jogging, running. May not have access to or money for a gym for other forms of exercise. May lack other equipment such as sneakers gym clothes, etc.	- Add objects to the Environment - Train to Restructure Environment - Time Management - Graded Tasks (duration) - Provide information on Where/When to perform the behaviour

ANEXO H: Avaliação do piloto com Coordenação de Equipe

- ☐ Termo de consentimento livre e esclarecido
- ☐ Gravação da entrevista

PERGUNTAS IMPULSOGOV

LEMBRAR de retomar brevemente quais foram as etapas que realizamos até aqui, para coordenadora ter um momento para lembrar como foi a iniciativa.

1. Qual foi o seu grau de satisfação com a iniciativa de Mensageria ao Cidadão? Escala de resposta: 1 a 5, sendo 01 “Muito insatisfeito” e 5 “Muito satisfeito”
- 1 a 5
2. Você pode descrever em uma frase qual foi a sua primeira impressão da iniciativa?
3. Quais foram os principais receios gerados no primeiro contato com a iniciativa?
4. A reunião de apresentação foi suficiente para compreender a iniciativa?
 - Sim
 - Não
 - Parcialmente
5. Se não ou parcialmente, o que seria necessário para garantir a devida compreensão da iniciativa? (ex. número/frequência de reuniões, conteúdo da apresentação)
6. Foi possível comunicar a equipe de saúde sobre a iniciativa em tempo hábil?
 - Sim
 - Não
 - Parcialmente
7. Quem foi comunicado sobre a iniciativa?
8. O conteúdo da mensagem estava adequado para a população do seu território?

9. Se não ou parcialmente, o que poderia ser melhorado?

10. A mensagem enviada com a relação de pessoas que realizaram o agendamento foi o suficiente para se organizarem na unidade afim de garantir o atendimento?

- Sim
- Não
- Parcialmente

11. Se não foi suficiente, o que seria necessário para garantir o atendimento?

12. O que foi feito a partir do recebimento desta mensagem de feedback para garantir esse atendimento?

13. [Tipo A - Disponibilidades] A mensagem “tipo A” é aquela que há incentivo de procurar a unidade para atendimento COM disponibilidades de horários para agendamento.

14. As disponibilidades para agendamento do atendimento que foram ofertadas aos usuários estavam adequadas ao fluxo de atendimento da unidade?

15. [Tipo B] A mensagem “tipo B” é aquela que há incentivo de procurar a unidade para atendimento, mas não são disponibilizados horários para agendamento.

16. Pessoas procuraram a unidade para atendimento a partir do recebimento da mensagem tipo B?

17. [Tipo B] Como a equipe de saúde acatou essa demanda de atendimento?

18. Que efeito a iniciativa teve na procura de serviços?

- Aumento
- Neutro

- Diminuição

19. Se houve um aumento, a equipe foi capaz de atender à demanda gerada pela iniciativa de mensagens? Se sim, como?
20. A equipe percebeu diferença no público que agendou a consulta? As pessoas que foram atendidas após receberem mensagens via WhatsApp eram as mesmas que já acessavam a unidade de saúde?
21. Durante o disparo de mensagens, houveram ações coletivas para coleta de citopatológico ou atendimento à pessoa com condição crônica?
(Ex.: mutirão de atendimento, ação em território para busca ativa, unidade móvel de atendimento)
22. Se sim, descrever iniciativas
23. Você participaria novamente da iniciativa de mensageria?

PERGUNTAS JOHN HOPKINS

24. Que mudanças ou adaptações você recomendaria à Impulso para continuar e expandir esta iniciativa?
25. A estrutura e os instrumentos disponíveis na unidade de saúde são adequados para atender às demandas (citopatologia, medida de pressão e glicação de hemoglobina) do serviço de saúde? A estrutura e as ferramentas disponíveis foram suficientes para participar na iniciativa de mensagens?
26. Você está ciente de outras experiências de mensagens (via WhatsApp ou outra rede social) que estão sendo realizadas?
27. Se sim, o que você sabe sobre esta iniciativa?

~voltando~

28. Que desafios você enfrentou (com a iniciativa de Mensageria)?

29. A iniciativa de mensageria beneficiou o seu trabalho? Se sim, que benefício identificou?

30. Quais receios tem hoje sobre o uso de Mensageria ao Cidadão?

PERGUNTAS DE PRODUTO

31. MENSAGERIA AO CIDADÃO: O quanto você ficaria desapontado se essa iniciativa não acontecesse mais?

- Nenhum pouco desapontado
- Um pouco desapontado
- Muito desapontado

32. MENSAGERIA AO CIDADÃO: Quanto tempo por semana você dedica à essa iniciativa?

- Em minutos

33. LISTAS NOMINAIS IP: O quanto você ficaria desapontado se essa iniciativa não acontecesse mais?

- Nenhum pouco desapontado
- Um pouco desapontado
- Muito desapontado

34. LISTAS NOMINAIS IP: Quanto tempo por semana você dedica à essa iniciativa?

- Em minutos

PERGUNTAS FINAIS DE MODELOS DE AGENDA

Agora, entramos na última etapa de perguntas, para entender um pouco mais como funciona a organização das agendas da sua equipe.

35. Qual o sistema/ferramenta utilizada hoje para a agenda da equipe? (eSUS, papel, planilhas, aplicativos, etc)
36. Você utiliza ou já utilizou alguma agenda digital?
37. Como é organizada a agenda da sua equipe de saúde? (demanda espontânea, programas, consultas por blocos, etc)
38. Hoje, como os usuários podem realizar e/ou agendar a coleta de citopatológico?
39. Hoje, como os usuários podem realizar e/ou agendar a consulta de acompanhamento da pessoa com condições crônicas (hipertensão/ diabetes) ?
40. Quais são os desafios que você identifica com a organização de agendamentos?
41. Como vocês definem as agendas? É dado pela secretaria ou vocês definem?/
42. Com que periodicidades vocês mudam essas agendas?

FECHAMENTO DA ENTREVISTA

- ☐ Encerramento da gravação
- ☐ Agradecimento
- ☐ Conferência do termo de consentimento

ANEXO I: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Avaliação do piloto com Coordenação de Equipe

Apresentação:

O Senhor ou a Senhora _____ (nome social), nascido/a na data de _____, no município de _____, está sendo convidado (a) a participar do estudo mensageria para atenção primária no Brasil.

Este documento é um termo de consentimento livre e esclarecido – isto significa que ele serve para documentar a sua concordância em participar da pesquisa, sem nenhum tipo de pressão e com todas as informações importantes sobre a sua participação.

a) Objetivo:

A pesquisa tem como objetivo, entender como foi a experiência de mensageria em seu município e como o mesmo afetou sua experiência com sua unidade de saúde da família.

b) Descrição da pesquisa:

A pesquisa será realizada por meio de entrevistas estruturadas. As entrevistas serão realizadas por um(a) pesquisador(a) treinado(a) que pode estar acompanhado de um assistente e durará aproximadamente 30 minutos.

c) Riscos e benefícios:

Não há riscos conhecidos associados a esta pesquisa.

d) Benefícios potenciais incluem:

- Contribuir para o conhecimento sobre como mensageria pode ser melhor adaptado a realidade das unidades de saúde da família do Brasil;

e) Direitos do participante:

A participação na pesquisa é voluntária. Se você concordar em participar, será solicitado a assinar este TCLE e responder a uma entrevista. Você tem o direito de:

- Recusar-se a participar da pesquisa;
- Parar de participar da pesquisa a qualquer momento;
- Solicitar uma cópia dos dados coletados sobre você

f) Confidencialidade:

Todas as informações coletadas durante a pesquisa serão mantidas confidenciais. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante.

g) Coleta e Armazenamento de Dados:

Durante a realização desta pesquisa, as entrevistas e/ou respostas serão gravadas em áudio e/ou vídeo para posterior análise. Além disso, as respostas fornecidas pelos participantes serão registradas nas plataformas Google Forms e Dovetail. Essas plataformas serão utilizadas para a organização e análise dos dados coletados. A gravação das entrevistas tem como objetivo garantir a precisão das informações e permitir uma análise detalhada das respostas. Os dados gravados serão armazenados de forma segura e serão acessíveis apenas à equipe de pesquisa. Todas as informações serão tratadas com confidencialidade e serão utilizadas exclusivamente para os fins desta pesquisa.

g) Consentimento:

Ao assinar este TCLE, você concorda em participar desta pesquisa. Você pode retirar seu consentimento a qualquer momento, sem penalidade.

h) Acompanhamento:

Em qualquer etapa, você pode acionar os responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. A principal investigadora é Gabrielle A. C. da Silva, que pode ser contactada no telefone +5511940211447, ou pelo e-mail gabrielle@impulsogov.org.

Assinatura do participante:

[Nome do participante]

Data:

PARTE 5

Referências

MUNDIAL, Banco. Propostas de reformas do sistema único de saúde brasileiro. **Washington, DC**, p. 1-16, 2018.

PAIVA, Fernando. Pesquisa Panorama: mensageria no Brasil.[S. l.]. **Mobile Time: Opinion Box**, 2021.

BETTLE, Rosie. Mass media interventions report. **Founders Pledge**, [S. l.], 22 nov. 2022. Disponível em: <https://www.founderspledge.com/research/mass-media-interventions>. Acesso em: 22 out. 2023.

RAHMAN, Md Obaidur et al. Effects of mhealth interventions on improving antenatal care visits and skilled delivery care in low-and middle-income countries: systematic review and meta-analysis. **Journal of Medical Internet Research**, v. 24, n. 4, p. e34061, 2022.

LINDE, Ditte S. et al. One-way SMS and healthcare outcomes in Africa: systematic review of randomised trials with meta-analysis. **PLoS One**, v. 14, n. 6, p. e0217485, 2019.

LUND, Stine et al. Mobile phone intervention reduces perinatal mortality in zanzibar: secondary outcomes of a cluster randomized controlled trial. **JMIR mHealth and uHealth**, v. 2, n. 1, p. e2941, 2014.

BROSSO, Samantha N. et al. Harnessing neuroimaging to reduce socioeconomic disparities in chronic disease: A conceptual framework for improving health messaging. **Frontiers in Human Neuroscience**, v. 15, p. 576749, 2021.

CARATÙ, Myriam. **Public policy, social marketing and neuromarketing: from addressing the consumer behaviour to addressing the social behaviour.** Tese de Doutorado. Sapienza University of Rome.